

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU
CENTRO DE EDUCAÇÃO, LETRAS E SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM REGIÃO DE
FRONTEIRA - MESTRADO**

Juliana Marçal

**EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UM OLHAR DA ENFERMAGEM SOBRE AS
PRÁTICAS EDUCATIVAS DO SETOR DE NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO EM REGIÃO DE FRONTEIRA**

FOZ DO IGUAÇU – PR

2026

Juliana Marçal

**EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UM OLHAR DA ENFERMAGEM SOBRE AS
PRÁTICAS EDUCATIVAS DO SETOR DE NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO EM REGIÃO DE FRONTEIRA.**

Versão Original

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira-Mestrado, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Saúde Pública.

Área de concentração: Saúde Pública em Região de Fronteira

Orientadora: Dra. Thais Fernanda Tortorelli Zarili

FOZ DO IGUAÇU – PR

2026

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Marçal, Juliana

Educação Permanente em Saúde: Um olhar da enfermagem sobre as práticas educativas do setor de núcleo de educação, pesquisa e extensão de um hospital público em região de fronteira / Juliana Marçal; orientadora Thais Fernanda Tortorelli Zarili. -- Foz do Iguaçu, 2026.

90 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Foz do Iguaçu)
-- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira, 2026.

1. Educação Permanente. 2. Saúde Pública. 3. Enfermagem.
4. Pesquisa Qualitativa. I. Tortorelli Zarili, Thais
Fernanda, orient. II. Título.

MARÇAL, J. **Educação permanente em saúde: um olhar da enfermagem sobre as práticas educativas do setor de núcleo de educação, pesquisa e extensão de um hospital público em região de fronteira.** 2026. 90p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Orientadora: Thais Fernanda Tortorelli Zarili. Foz do Iguaçu, 2026.

Aprovado em 23/02/2026

BANCA EXAMINADORA:

Documento assinado digitalmente
 **THAIS FERNANDA TORTORELLI ZARILI**
Data: 27/04/2026 11:04:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. (a) Thais Fernanda Tortorelli Zarili

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Documento assinado digitalmente
 **DENISE RISSATO**
Data: 27/04/2026 10:55:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. (a) Denise Rissato

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste

Documento assinado digitalmente
 **DINAIR FERREIRA MACHADO**
Data: 26/04/2026 21:29:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. (a) Dinair Ferreira Machado

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP

Dedico este trabalho a todos que, de alguma forma, contribuíram para que esta pesquisa se tornasse possível. A Deus, pela força espiritual imensurável que me sustentou durante todo o processo. À minha orientadora, pela paciência e pela sabedoria ao me conduzir pelo caminho correto. À minha família, por permanecer ao meu lado, fortalecendo-me e oferecendo apoio em cada momento de dificuldade. Aos meus colegas de trabalho, que colaboraram e caminharam comigo ao longo desta trajetória acadêmica. E a todos que, nos momentos de maior desafio, me ofereceram apoio, paciência e incentivo, deixo meu sincero agradecimento.

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.

(Paulo Freire - Pedagogia da autonomia, 1996)

MARÇAL, J. **Educação permanente em saúde: um olhar da enfermagem sobre as práticas educativas do setor de núcleo de educação, pesquisa e extensão de um hospital público em região de fronteira.** 2026. 90p. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Orientadora: Thais Fernanda Tortorelli Zarili. Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, demandando processos formativos que contribuam para a qualificação do trabalho em saúde e para a consolidação de práticas assistenciais coerentes com esses pressupostos. Nesse contexto, a Educação Permanente em Saúde (EPS) configura-se como estratégia central para o desenvolvimento dos trabalhadores, ao articular formação, gestão e cuidado a partir do cotidiano dos serviços. O presente estudo teve como objetivo analisar as práticas educativas desenvolvidas pelo Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão de um hospital público localizado em região de fronteira, sob a perspectiva da equipe de enfermagem. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, composto por duas etapas complementares: uma revisão integrativa da literatura e uma pesquisa empírica com profissionais de enfermagem. A revisão integrativa foi realizada em bases de dados nacionais e internacionais, com análise temática dos estudos incluídos. A etapa empírica contou com entrevistas semiestruturadas, conduzidas em ambiente institucional reservado, gravadas em áudio, transcritas integralmente e validadas pelos participantes. A definição do número de entrevistados seguiu critérios de diversidade profissional e de setores, priorizando a compreensão aprofundada das experiências no contexto investigado. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo, orientada pelas etapas de pré-análise, exploração do material e interpretação dos resultados. Os resultados evidenciaram que os participantes reconhecem a relevância das ações educativas para a atualização profissional, a segurança do paciente e o fortalecimento de competências técnicas e relacionais. Contudo, também foram identificados limites relacionados às condições de trabalho, à organização institucional e à disponibilidade de tempo para participação nas atividades formativas. Conclui-se que a efetivação da EPS no contexto hospitalar, especialmente em regiões de fronteira, requer maior articulação institucional, estratégias pedagógicas contextualizadas e condições organizacionais que favoreçam a integração entre educação e prática profissional, contribuindo para a qualificação da assistência e o fortalecimento do SUS.

Palavras-chave: Educação Permanente; Hospital; Pesquisa Qualitativa; Enfermagem, Saúde na Fronteira.

MARÇAL, J. **Permanent education in health: a nursing perspective on the educational practices of the education, research and extension center sector of a public hospital in a border region.** 2026. 90p. Dissertation (Master's Degree in Public Health in Border Region) – State University of Western Paraná. Advisor: Thais Fernanda Tortorelli Zarili. Foz do Iguaçu, 2026.

ABSTRACT

The Unified Health System (SUS) is based on the principles of universality, integrality and equity, demanding training processes that contribute to the qualification of health work and to the consolidation of care practices consistent with these assumptions. In this context, Permanent Health Education (PEH) is a central strategy for the development of workers, by articulating training, management and care based on the daily routine of the services. The present study aimed to analyze the educational practices developed by the Education, Research and Extension Center of a public hospital located in a border region, from the perspective of the nursing team. This is a qualitative study, consisting of two complementary stages: an integrative literature review and empirical research with nursing professionals. The integrative review was carried out in national and international databases, with thematic analysis of the included studies. The empirical stage included semi-structured interviews, conducted in a reserved institutional environment, recorded in audio, fully transcribed and validated by the participants. The definition of the number of interviewees followed criteria of professional and sector diversity, prioritizing the in-depth understanding of the experiences in the investigated context. The data were submitted to Content Analysis, guided by the stages of pre-analysis, exploration of the material and interpretation of the results. The results showed that the participants recognize the relevance of educational actions for professional updating, patient safety and the strengthening of technical and relational skills. However, limits related to working conditions, institutional organization and the availability of time to participate in training activities were also identified. It is concluded that the effectiveness of PHE in the hospital context, especially in border regions, requires greater institutional articulation, contextualized pedagogical strategies and organizational conditions that favor the integration between education and professional practice, contributing to the qualification of care and the strengthening of the SUS.

Keywords: Continuing Education; Hospital; Qualitative Research; Nursing, Health on the Border.

MARÇAL, J. Educación permanente en salud: una perspectiva de enfermería sobre las prácticas educativas del sector de centros educativos, de investigación y extensión de un hospital público en una región fronteriza. 2026. 90p. Tesis (Máster en Salud Pública en la Región Fronteriza) – Universidad Estatal de Paraná Occidental. Asesora: Thais Fernanda Tortorelli Zarili. Foz do Iguaçu, 2026.

RESUMEN

El Sistema Unificado de Salud (SUS) se basa en los principios de universalidad, integridad y equidad, exigiendo procesos formativos que contribuyan a la cualificación del trabajo sanitario y a la consolidación de las prácticas de atención coherentes con estos supuestos. En este contexto, la Educación Permanente en Salud (PEH) es una estrategia central para el desarrollo de los trabajadores, articulando la formación, la gestión y el cuidado basándose en la rutina diaria de los servicios. El presente estudio tuvo como objetivo analizar las prácticas educativas desarrolladas por el Centro de Educación, Investigación y Extensión de un hospital público situado en una región fronteriza, desde la perspectiva del equipo de enfermería. Se trata de un estudio cualitativo, compuesto por dos etapas complementarias: una revisión integrativa de la literatura y una investigación empírica con profesionales de enfermería. La revisión integradora se llevó a cabo en bases de datos nacionales e internacionales, con análisis temático de los estudios incluidos. La etapa empírica incluyó entrevistas semiestructuradas, realizadas en un entorno institucional reservado, grabadas en audio, completamente transcritas y validadas por los participantes. La definición del número de entrevistados siguió criterios de diversidad profesional y sectorial, priorizando la comprensión profunda de las experiencias en el contexto investigado. Los datos se enviaron a Análisis de Contenido, guiados por las etapas de preanálisis, exploración del material e interpretación de los resultados. Los resultados mostraron que los participantes reconocen la relevancia de las acciones educativas para la actualización profesional, la seguridad del paciente y el fortalecimiento de habilidades técnicas y relacionales. Sin embargo, también se identificaron límites relacionados con las condiciones laborales, la organización institucional y la disponibilidad de tiempo para participar en actividades formativas. Se concluye que la eficacia de la PHE en el contexto hospitalario, especialmente en regiones fronterizas, requiere una mayor articulación institucional, estrategias pedagógicas contextualizadas y condiciones organizativas que favorezcan la integración entre educación y práctica profesional, contribuyendo a la cualificación de la atención y al fortalecimiento del SUS.

Palabras clave: Educación Continua; Hospital; Investigación Cualitativa; Enfermería, Salud en la Frontera.

LISTA DE SIGLAS

- APS** – Atenção Primária à Saúde
- CAAE** – Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
- CEP** – Comitê de Ética em Pesquisa
- CIES** – Comissões de Integração Ensino-Serviço
- COREQ** – *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research*
- DECS** – Descritores em Ciências da Saúde
- EC** – Educação Continuada
- EIP** – Educação Interprofissional em Saúde
- EP** – Educação Permanente
- EPS** – Educação Permanente em Saúde
- HMPGL** – Hospital Municipal Padre Germano Lauck
- MeSH** – *Medical Subject Headings*
- MS** – Ministério da Saúde
- NEPE** – Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão
- NEPS** – Núcleos de Educação Permanente em Saúde
- OMS** – Organização Mundial da Saúde
- PNEPS** – Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
- PNH** – Política Nacional de Humanização
- PRISMA** – *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*
- PVO** – *Patient, Variable, Outcomes*
- SUS** – Sistema Único de Saúde
- TCLE** – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
- UNESCO** – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
- UNICEF** – Fundo das Nações Unidas para a Infância
- UTI** – Unidade de Terapia Intensiva
- WHO** – *World Health Organization*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS SEGUNDO O PRISMA ADAPTADO.....	47
--	-----------

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – CHAVES DE BUSCA APLICADAS ÀS BASES DE DADOS ELETRÔNICAS.....	45
QUADRO 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA.....	47

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	15
1.1	EPS EM REGIÃO DE FRONTEIRA: ESTRATÉGIAS DE CUIDADO, TERRITORIALIDADES E INTERSETORIALIDADES.	22
1.2	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: DESAFIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE APRENDIZADO NO TRABALHO.	25
2.	JUSTIFICATIVA.....	29
3.	OBJETIVO.....	31
3.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	31
4.	PERCURSO METODOLÓGICO	32
4.1	TIPO DE ESTUDO	32
4.2	REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	32
4.3	AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO NEPE	34
4.3.1	Local de Estudo.....	34
4.4	DESENHO DO ESTUDO	35
4.4.1	Participantes e critérios de inclusão e exclusão	35
4.4.2	Coleta de dados	35
4.4.3	Análise dos dados.....	36
4.4.4	Aspectos éticos e legais	37
5.	RESULTADOS	39
	ARTIGO 1: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR: REVISÃO INTEGRATIVA	40
	ARTIGO 2: AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA FRONTEIRA: OLHAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM HOSPITALAR.....	57
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	76
	REFERÊNCIAS	78
	APÊNDICE 1 – Roteiro de Questões para a Entrevista	85

Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)	87
Anexo 1 – TERMO DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)	89

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído no Brasil pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990, com os objetivos de identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, formular políticas públicas voltadas a assistência às pessoas por intermédio de ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde (Brasil, 1988; 1990).

Cabe mencionar que a criação do SUS ocorreu no contexto da redemocratização nacional, como resultado da intensa mobilização e articulação política de alguns setores da sociedade civil brasileira que lutavam por uma Reforma Sanitária no país, comprometida com a promoção da saúde e a garantia do acesso igualitário, integral e universal à saúde. Para isso, tanto legisladores, gestores públicos e trabalhadores da saúde, quanto pesquisadores e os movimentos sociais inspiraram-se em documentos internacionais produzidos, em diferentes momentos históricos, que versavam sobre a necessidade de implementação, por parte dos governos nacionais, de ações e políticas públicas voltadas à promoção da saúde, tais como a Declaração de Alma-Ata de 1978 (OMS, 1978), a Carta de Ottawa de 1986 (OMS, 1996) e a Declaração de Adelaide de 1988 (Brasil, 1988b).

Contudo, mesmo tendo sido criado há mais de três décadas, de acordo com De Souza (2025), o SUS ainda enfrenta desafios para a sua efetivação, seja para assegurar o acesso universal, integral e equitativo à atenção à saúde, seja para atuar na promoção, proteção e na recuperação da saúde, como medidas assistenciais ou preventivas, e até mesmo para garantir a prática humanizada conforme o princípio da humanização, inserido recentemente no arcabouço normativo (Brasil, 2025). De Souza (2025) destaca que as principais questões a serem enfrentadas para que o SUS possa seguir ampliando o seu alcance social são o subfinanciamento do SUS, a infraestrutura inadequada e insuficiente, a desigualdade no acesso aos serviços, distribuição desigual da tecnologia em saúde e de profissionais de saúde no território. Para o autor, a superação de tais problemas requer investimentos não apenas em inovações tecnológicas, mas também em educação em saúde e formação profissional, tanto para gestores quanto para os profissionais de saúde.

Independentemente dos avanços já conquistados na saúde brasileira desde a sua criação, o SUS é uma política pública ainda em construção, que precisa ser continuamente aprimorada, a fim de que possa, cada vez mais, se aproximar do ideal representado por seus princípios e objetivos (De Souza, 2025), mas para isso necessita de profissionais

comprometidos com tais princípios e objetivos (Ferreira; Cerdeira, 2020; De Souza, 2025).

Com o intuito de fortalecer o SUS, o Ministério da Saúde tem adotado diversas medidas, ao longo dos anos. Dentre elas, destacam-se as políticas voltadas para a reorientação da formação e do trabalho em saúde que buscam, historicamente, enfrentar os desafios que dificultam a execução dos princípios do sistema que se dividem em dois eixos principais: a Educação Permanente em Saúde (EPS) e a Educação Interprofissional em Saúde (EIP). A EPS refere-se às ações realizadas no âmbito da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) pelo SUS para a qualificação dos trabalhadores do setor, enquanto a EIP uma abordagem colaborativa de formação profissional em saúde de diferentes áreas, adotada internacionalmente desde os anos 1970 e que tem ganhado espaço no Brasil na última década (Ferreira; Cerdeira, 2020).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) adotou o conceito de qualificação do capital humano no final da década de 1960, considerando-o um dos componentes mais essenciais para o desenvolvimento e a produtividade econômica de uma nação. A EPS surge no Brasil na década de 1980 como uma estratégia para superar o modelo tradicional de "educação continuada", caracterizado pela atualização pontual de conhecimentos específicos para determinadas categorias profissionais, pois esse modelo não atendia às novas demandas dos serviços de saúde. Em contrapartida, a EPS propõe uma abordagem inovadora, voltada à transformação das práticas e com foco no ambiente de trabalho, visando uma melhoria contínua e integrada das atividades profissionais (Brasil, 2004).

Além disso, Ubessi *et al.*, (2021) também acrescenta às estratégias de educação e formação em saúde fomentadas pelo Ministério da Saúde (MS), a educação em serviço, que diz respeito a formação de trabalhadores e estudantes na área da saúde por meio de práticas interdisciplinares e de autogestão, com vistas a fortalecer a participação ativa e emancipatória em coletivos e nas relações ensino-serviço, especialmente em experiências e estágios no SUS.

A PNEPS refere-se à política pública de formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, criada em 2004 pela Portaria nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, enquanto as diretrizes para a sua implementação foram estabelecidas pela Portaria 1.996, de 20 de agosto de 2007 (Brasil, 2007). Esta última constituiu grande avanço ao fomentar a condução regional da política e a participação interinstitucional, por meio das Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES), além de definir orçamento para projetos e ações, estabelecendo critérios de alocação transparentes e explícitos (Brasil, 2018).

A PNEPS é considerada uma estratégia do SUS e visa contribuir para a organização dos serviços de saúde, através de qualificações que busquem a formação e o desenvolvimento dos profissionais e trabalhadores da saúde, articulando a integração entre o ensino e serviço, com vistas ao fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS (Brasil, 2014). Assim, a EPS é uma estratégia pedagógica que visa direcionar o processo de trabalho em saúde, qualificando e aperfeiçoando os meios de trabalho e a qualidade do mesmo para um atendimento mais humanizado, tendo como base uma EPS que engloba capacitações específicas para a área de saúde (Brasil, 2004).

Nesse sentido, segundo Jacobovski e Ferro (2021), a EPS busca romper o modelo tradicional de ensino e sugerir uma interação entre ensino, serviço e comunidade, aliando-se maneiras de transformar e fortalecer as ações educativas e os processos de trabalho em saúde, assim como as relações interpessoais na realidade concreta dos territórios no dia a dia de trabalho.

A PNEPS sugere uma reavaliação do processo formativo à luz dos princípios do SUS, priorizando-os em relação aos modelos educacionais tradicionais estabelecidos ao longo da história. Nesse contexto, a PNEPS deve ser entendida não como uma ferramenta pedagógica ou um método de ensino, mas sim como um sistema complexo que se inicia com o trabalho em saúde, envolvendo as equipes nos serviços e integrando diversos protagonistas nesse debate – configurando assim uma política de educação interprofissional (Figueiredo *et al.*, 2022).

A PNEPS visa o processo de trabalho e o desenvolvimento dos profissionais por meio da articulação constante entre ensino e serviço. Ele visa não apenas a formação, mas também a qualificação da administração e do processo de trabalho em saúde. A análise das ações realizadas pelo MS em 2017 e 2018 para retomar a implementação da PNEPS revela que os gestores tinham compreensão limitada sobre a EPS e o funcionamento dos CIES. Isso resultou em uma articulação insuficiente entre os elementos da formação, financiamento inadequado, modelos de formação ainda tradicionais com reprodução de cursos e baixa apropriação dos conceitos essenciais da EPS (Ogata *et al.*, 2021).

Percebe-se como necessária a avaliação do serviço de EPS da instituição hospitalar, seja em sua capacidade de planejamento como das atividades idealizadas e executadas como estratégia de educação do trabalhador. Nas organizações hospitalares, a aplicabilidade de um serviço de capacitação e treinamento não é realizada por apenas um setor e sim, por equipes que estejam trabalhando tendo como propósito em conjunto o desenvolvimento do ofício na

prática laboral, o cuidado direto ou indireto e seu impacto na qualidade da assistência prestada (Bitencourt *et al.*, 2021).

Diante do contexto de fronteira, que é o campo de abrangência da pesquisa, discorre-se sobre a fragmentação (que ocorre entre setores e coordenação de serviços e profissionais) das instituições hospitalares, no que diz respeito tanto à organização estrutural quanto à atuação dos profissionais de saúde. É primordial analisar como esses fatores influenciam a gestão da EPS. Essa análise é particularmente relevante no contexto da segurança do paciente e da qualidade assistencial, considerando que a educação é uma ferramenta essencial para promover uma assistência mais segura e eficaz. Além disso, a qualidade do atendimento hospitalar está intrinsecamente ligada à competência e à atuação dos profissionais que trabalham nesse ambiente. Desse modo, pode-se dizer que a qualidade de atenção hospitalar está interligada com a qualidade da assistência ofertada pelas atividades dos profissionais nesse cenário (Alzahrani; Jones; Abdel-Latif, 2018).

Percebe-se que a prática de EPS nas instituições hospitalares ainda se encontra atrelada a muitos obstáculos. Assim, necessita-se da elaboração de estratégias educativas e gerenciais eficientes, que propiciem a execução completa dessas atividades, e que os profissionais busquem a melhoria da qualidade frente aos desafios enfrentados em um hospital público (Parente *et al.*, 2024).

Os estudos de Macedo *et al.*, (2019) e Silva *et al.*, (2021) mostram que a dificuldade de sensibilizar os profissionais para engajar-se nas atividades são por conta dos desinteresses e desmotivação dos mesmos devido à sobrecarga de trabalho ou também pelos poucos profissionais nos setores, e em muitos casos a não liberação de participação nas atividades de EPS pelos gestores setoriais. Com isso, há uma grande lacuna nas EPS frente aos treinamentos e capacitações, gerando assim uma falha na formação continuada dos profissionais.

Embora frequentemente utilizadas como sinônimos no cotidiano dos serviços de saúde, a Educação Continuada (EC) e a EPS constituem concepções distintas do processo formativo. A EC, de modo geral, está associada a ações pontuais de atualização técnico-científica, centradas na transmissão de conteúdos e na lógica de cursos, treinamentos e capacitações. Já a EPS, conforme preconizado pela PNEPS, propõe uma abordagem crítico-reflexiva, ancorada no cotidiano do trabalho, na problematização das práticas e na transformação dos processos de cuidado e gestão (Brasil, 2004; Ceccim; Feuerwerker, 2004).

No entanto, na realidade institucional dos serviços de saúde, especialmente no

contexto hospitalar, observa-se que as ações formativas frequentemente transitam entre essas duas perspectivas, sem uma distinção conceitual clara. Atividades denominadas como EPS muitas vezes assumem características próprias da EC, revelando uma tensão entre o desenho normativo da política e sua materialização no cotidiano do trabalho. Reconhecer essa sobreposição não fragiliza a análise desenvolvida nesse estudo, mas permite compreender os limites e possibilidades da EPS tal como ela é efetivamente vivenciada pelos trabalhadores da saúde.

Nesse sentido, o presente estudo adotou a EPS como referencial analítico, compreendendo que as práticas educativas desenvolvidas no contexto hospitalar investigado expressam simultaneamente elementos da EC e da EPS, sendo essa ambiguidade parte constitutiva da realidade analisada.

No estudo realizado por Bitencourt *et al.*, (2021), que teve como objetivo analisar o serviço de EPS com base nos fundamentos propostos por Avedis Donabedian, os resultados indicaram que a EPS representa uma mudança de perspectiva sobre a realidade da saúde. Com a colaboração de diferentes setores, a EPS pode melhorar os indicadores de saúde e se tornar mais eficaz. O autor observou que é essencial que a EPS funcione como um elo não apenas entre setores, mas também entre os profissionais da área, de modo que a capacitação se traduza em uma assistência de qualidade. No entanto, ele destaca que ainda existem diversas implicações que vão além da atuação dos profissionais, sendo necessário um incentivo maior e uma promoção mais ativa por parte de todos os envolvidos nas ações relacionadas à EPS.

Segundo Bossan *et al.* (2024), que aborda sobre o estudo de indicadores qualitativos de EPS, existem diversos obstáculos para a implementação da EPS. É imprescindível que haja articulação e motivação entre os profissionais para que esse processo se torne efetivo. Há ainda, uma dificuldade em compreender o conceito das políticas públicas de EPS, o que dificulta a construção de indicadores específicos. Diante disso, ressalta-se a necessidade de fortalecer a consciência, tanto entre os profissionais de assistência quanto dos gestores, sobre a relevância da EPS. Além disso, é essencial desenvolver ações educativas que chamem a atenção dos profissionais para a importância da EPS e os benefícios que ela pode trazer para um atendimento mais eficaz.

De acordo com Yamamoto, Machado e Silva Junior (2015), a EPS é compreendida como um processo contínuo que contextualiza os profissionais da área. Esse processo estimula uma reflexão que busca promover mudanças nas práticas diárias. A EPS atua como uma ferramenta que integra teoria e prática, tendo o profissional de saúde como seu principal

protagonista. Nesse contexto, a integralidade do SUS exige ações específicas que atendam às necessidades dos usuários, levando em consideração os aspectos biopsicossociais da saúde. Assim, os autores defendem que a conexão entre EPS e integralidade pode ser uma estratégia eficaz, contribuindo para uma formação que una prática e avaliação. Isso permite que os profissionais reflitam sobre suas atividades, revisem suas abordagens e desenvolvam novas formas de atuação e responsabilidade no cuidado com a saúde.

Assim sendo, o objetivo da PNEPS é melhorar a integração entre os vários atores do processo de formação em saúde, incluindo instituições de ensino, serviços de saúde e gestores públicos. Eles funcionam como locais de cooperação e articulação, incentivando a troca de experiências e conhecimentos entre diferentes setores e promovendo o desenvolvimento de práticas contextualizadas e inovadoras (Brasil, 2007).

Assim, a EPS mostrou a necessidade de abandonar a ideia de que a baixa eficácia das ações de saúde se deve apenas à falta de capacitação dos profissionais. Em seu lugar, promoveu espaços de troca de saberes e análise do cotidiano, fortalecendo a coprodução de novas perspectivas e práticas em saúde, além de incentivar uma diferente forma de desenvolvimento dos sujeitos envolvidos. Essa abordagem reconhece que o conhecimento é construído em um ambiente compartilhado por diversos atores da saúde – como usuários, gestores, profissionais de distintas áreas e movimentos sociais. Nesse modelo de formação em serviço, todos os envolvidos têm igual oportunidade de compartilhar saberes, sendo considerados igualmente fundamentais para impulsionar mudanças sociais (Capra, 2011; Freire, 2020).

Desse modo, os estudos sobre avaliações de Educação Permanente (EP) se deram inicialmente em âmbito internacional na década de 1970, onde vários pesquisadores analisavam as ações educativas que consistia em variáveis, isso resultaria na influência direta nas ações dos participantes e para a organização. No Brasil, a psicologia organizacional, desde seus primórdios, busca avaliar as produções em conjunto com as ações educativas, integrando três etapas principais: avaliação de necessidades, planejamento e execução e avaliação dos efeitos. Esse processo cria um fluxo contínuo de informações, permitindo uma avaliação constante e permanente para o aprimoramento do sistema, alinhando-se aos princípios da EP, que visam um desenvolvimento contínuo e adaptativo das práticas organizacionais em saúde (Lopes *et al.*, 2020).

Nesse sentido, analisar as práticas educativas no interior dos serviços de saúde implica compreender como essas ações são percebidas e vivenciadas pelos trabalhadores no cotidiano

do trabalho. Mais do que avaliar programas a partir de critérios normativos, interessa compreender os sentidos atribuídos às ações formativas e suas repercussões na prática profissional, em consonância com os pressupostos da EPS, que privilegia a reflexão crítica sobre o processo de trabalho como motor de transformação das práticas assistenciais.

Assim, as faltas de motivação com os temas propostos e as atividades elaboradas requerem que os profissionais sejam estimulados nos processos educativos e de formação permanente, compreendendo a sua com a própria qualificação e capacitação. Os estudos apontam ainda as dificuldades quanto à realização de ações da EPS, nas instituições de saúde, principalmente em razão da baixa adesão dos profissionais e da resistência em aprender novos conhecimentos (Sade *et al.*, 2020).

Dessa forma, a EPS é apresentada como um processo contínuo e interligado de aprendizado no ambiente de trabalho, que promove transformações nas práticas profissionais conforme as demandas dos serviços de saúde. Bitencourt *et al.* (2021) consideram indicadores como métricas fundamentais para avaliar o desempenho, detectar lacunas e guiar decisões, além de usar os pilares de qualidade de Donabedian - eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade - como referência para analisar os efeitos da EPS e orientar a criação de indicadores de avaliação. Assim gestores, educadores e profissionais de saúde atuam como protagonistas na melhoria contínua dos serviços de saúde.

Entende-se que as ações de EPS devem ser avaliadas pelos mesmos princípios que conduzem a prática, ou seja, aspectos que envolvem uma abordagem participativa, abrangendo de forma dialógica os distintos sujeitos, relacionados com a execução das ações e com as mudanças pretendidas no processo de trabalho. Assim, a avaliação não é uma punição, mas uma reflexão da aprendizagem adquirida e para um melhor resultado na sua propagação de transferência de conhecimento e assimilação do conteúdo proposto (Brasil, 2022).

O desenvolvimento dos serviços de saúde baseia-se, prioritariamente, na capacitação e na superação de obstáculos operacionais. Entende-se a capacitação como um processo intencional para suprir lacunas de conhecimento que a dinâmica organizacional não resolve naturalmente. Contudo, esse processo enfrenta limites práticos, como a escassez de recursos, a alta demanda de trabalho e culturas institucionais pouco flexíveis. Conforme destaca Brasil (2009), o êxito da capacitação não depende apenas do treinamento em si, mas de um conjunto de circunstâncias políticas e ideológicas que determinam suas reais possibilidades de impacto.

O desenvolvimento de novos critérios é definido como a aprendizagem ou habilidades necessárias para resolver problemas e revisar padrões que impedem a resolução. O termo

"aprendizagem organizacional" tem sido utilizado por diversos autores para descrever situações em que as individualidades são integradas, compartilhadas e colocadas em ação por meio da coordenação das condutas de indivíduos distintos, incluindo aqueles em diferentes posições de hierarquia e poder. Isso se deve ao fato de que a aprendizagem é, essencialmente, um processo individual, pois somente os indivíduos são capazes de aprender. Portanto, é crucial considerar a coerência e a conexão entre as propostas de capacitação e as políticas de transformação dos serviços de saúde, especialmente em períodos de mudanças ou reformas (Araújo, 2019; Brasil, 2009; Capra, 2011).

1.1 EPS EM REGIÃO DE FRONTEIRA: ESTRATÉGIAS DE CUIDADO, TERRITORIALIDADES E INTERSETORIALIDADES.

É importante observar que o Brasil possui uma vasta área de fronteira compartilhada com 10 nações da América do Sul, onde existem 588 municípios distribuídos por 11 estados, com 139 deles localizados no Paraná. As regiões de fronteira são complexas e devem ser compreendidas além do aspecto jurídico formal, considerando o cotidiano dos espaços e limites, onde coexistem tanto elementos de integração quanto conflitos. Esses fatores são essenciais para entender o processo saúde-doença e, conseqüentemente, para a formulação de políticas e programas de saúde adequados. O território pode ser visto como um espaço social historicamente moldado, imerso em relações de poder e influenciado por redes e identidades em constante mudança, além da forte intervenção do capital e do Estado. A fronteira serve como um recorte analítico e espacial que revela diversas realidades políticas, econômicas e culturais, destacando a volatilidade do capital e as relações de produção que permeiam esse território (Brasil, 2016; Haum; Carvalho, 2021).

Como citado no estudo de Timóteo *et al.* (2023) nas regiões de fronteira são encontradas populações com as mais diversas características multiculturais, as quais instituem desafios na disponibilização da oferta de cuidados de enfermagem. O atendimento de populações culturalmente diversas exige muitas vezes a desconstrução de conceitos e estratégias de atuação, de modo a levar em conta a necessidade de saúde do paciente bem como, a suas experiências de saberes familiar e suas crenças culturais. Diante disso, notou-se que a formação dos enfermeiros é primordial na questão do cuidado cultural, principalmente em região de fronteira, pois com isso, poderiam minimizar as dificuldades encontradas nos atendimentos.

Nesse cenário, o papel do enfermeiro se torna crucial para os cuidados da população que vive em áreas de fronteira, tanto na gestão quanto na assistência. Esse profissional atua alinhado à regulamentação e à implementação dos princípios e diretrizes do SUS, contribuindo para fortalecer as relações entre a comunidade e os profissionais de saúde. O enfermeiro desempenha uma função central na organização do cuidado, uma vez que suas atribuições gerenciais são resultado da evolução histórica da profissão. Pensadores da saúde têm trabalhado para validar a ampliação das competências gerenciais como uma estratégia para aumentar a produtividade dos profissionais, especialmente frente às novas demandas do mercado de trabalho (Souza; Dias; Silva, 2025; Souza *et al.*, 2023).

Fontana (2019) e Crespo *et al.* (2021) enfatizam que a adoção de currículos por competências no ensino em diversas áreas do cuidado oportuniza um diferencial na construção de ensino de enfermeiros que, com a prática, terão melhores condições de aplicar a competência cultural no cuidado à saúde, em concordância das necessidades locais da região de fronteira. Assim, é fundamental fortalecer o conhecimento da equipe de enfermagem em práticas baseadas em evidências científicas e não apenas no senso comum diário em que o profissional vivencia no seu cotidiano. Assim, em um hospital de fronteira, a EP dos profissionais de saúde assume um papel relevante, pois a formação contínua não se limita apenas a aprimorar competências técnicas, mas também a desenvolver habilidades, como a comunicação intercultural, gestão de crises e adaptação às condições de saúde emergentes que podem variar entre diferentes populações. Essa interligação entre EP e práticas de saúde é fundamental para garantir um atendimento de qualidade e eficaz nas regiões de fronteira.

Ogata *et al.*, (2021) salienta que a valorização dos diversos saberes profissionais e uma ativa participação dos usuários é essencial tanto na EIP quanto na EPS, esse movimento têm como meta atender às necessidades de saúde dos usuários, seus familiares e toda a comunidade, com foco na integridade do cuidado no SUS. Dessa forma, a EIP e a EPS são parâmetros para transformar as práticas de saúde e educação, sem perder as raízes do âmbito político para sua implementação, sendo indispensável a mobilização social de toda a categoria de saúde e educação, superando os conflitos relacionados ao embate de saberes e poderes, pois, com essa união há uma construção de um sistema de saúde público integral e resolutivo.

Nesse contexto, os Núcleos de Educação Permanente em Saúde (NEPS) emergem como ferramentas importantes de gestão organizacional no setor de saúde. Esses núcleos não apenas aprimoram as competências dos trabalhadores, mas também elevam a qualidade dos serviços prestados. Além disso, fomentam o sentimento de pertencimento à área de atuação do

profissional, fortalecendo o trabalho em equipe e a colaboração integrada. Eles contribuem para a promoção da saúde dos trabalhadores, facilitando a divisão de responsabilidades e encaminhamentos eficazes, e promovem uma conexão mais estreita entre a educação e a prática profissional (Pereira; Rosa, 2020).

Nesse contexto, Bezerra e Dias (2022) apontam que os desafios relacionados à implementação e efetivação da EPS nas instituições de saúde, em muitos casos estão associados a um apoio das gerências dos serviços de saúde para que se tenha uma maior efetivação dessas práticas de EC. Assim, é imprescindível identificar os setores da instituição de saúde que contribuem para o aumento dessas problemáticas referente a EPS, permitindo a proposição de estratégias mais eficientes e eficazes para superar os obstáculos de desinteresse e desmotivação, e assim, promover ações que visam melhorias contínuas juntamente com os profissionais de saúde. Considerando as táticas de superação dos reveses para a efetivação da PNEPS, compete à gestão verificar quais se adéquam à sua realidade para o desenvolvimento das ações, priorizando a qualidade para que possam atender ao seu quantitativo e objetivo dos profissionais envolvidos no processo da EPS.

Segundo Almeida (2024), a educação em saúde constitui uma prática central no campo da saúde coletiva, ao considerar ações desenvolvidas em diferentes organizações e instituições do sistema de saúde. No entanto, tais ações não devem se restringir a práticas educativas isoladas, devendo articular-se às especificidades dos sujeitos e dos contextos em que se inserem. Nesse sentido, ainda que a EPS se desenvolva no interior das instituições, seus pressupostos dialogam com abordagens da educação popular ao reconhecer a diversidade de sujeitos como elemento central para a problematização das práticas e a transformação do processo de trabalho em saúde.

Contudo, a corresponsabilização e o compromisso de gestores e trabalhadores do SUS são pilares fundamentais. Nesse sentido, é vital refletir sobre como a educação em serviço molda a prática profissional. Esse processo de formação é um dos maiores desafios do sistema, pois exige transformações profundas e contínuas, tanto nas instituições quanto nas atitudes individuais de quem atua nas áreas de Saúde e Educação (Muñoz; Freitas; Sousa, 2020).

As práticas de educação em saúde devem sempre considerar as realidades sociais, incentivando os gestores das políticas a dedicarem atenção especial ao planejamento e organização dos serviços de saúde, à execução das ações de cuidado e à gestão territorial da saúde. A abordagem da saúde extrapola o campo isolado, propondo uma interlocução

intersetorial entre políticas, ampliando o debate para além da especificidade da saúde e incorporando as questões sociais vigentes, com suas demandas e necessidades. Compreender a saúde como o completo bem-estar físico, social e mental da população é essencial. Por fim, idealizar alternativas e práticas em educação em saúde implica transformar os modos de vida coletivos, promovendo a qualidade de vida e saúde por meio de estratégias construídas em conjunto, especialmente adaptadas às regiões de fronteira (Almeida, 2024).

1.2 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: DESAFIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE APRENDIZADO NO TRABALHO.

A EPS é um processo dinâmico e contínuo de formação e aprendizado que acompanha os profissionais ao longo de sua trajetória, com o objetivo de atualizar, aperfeiçoar e transformar seus conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Esse processo busca não apenas atender às demandas e avanços do campo da saúde, mas também promover uma prática assistencial mais eficaz, resolutiva e humanizada. Diferentemente da abordagem tradicional, a EPS se destaca por sua flexibilidade e por estar intrinsecamente conectada às necessidades dos profissionais, das equipes e das comunidades, valorizando a contextualização e o diálogo como pilares fundamentais para o desenvolvimento e impacto positivo na área da saúde (Almeida *et al.*, 2019).

A aprendizagem contínua no ambiente de trabalho potencializa a segurança profissional e a satisfação pessoal, gerando um impacto positivo na qualidade do cuidado. Além de elevar a realização profissional, a estruturação de ações de educação permanente é uma ferramenta essencial para mitigar os efeitos da rotatividade, garantindo que o conhecimento e as práticas sejam preservados e evoluam dentro das instituições (Khalili *et al.*, 2020; Menang *et al.*, 2023).

A literatura aponta que as estratégias de formação desenvolvidas nos serviços de saúde assumem múltiplos formatos, incluindo oficinas, treinamentos presenciais, conferências, atividades mediadas por tecnologias digitais, distribuição de materiais educativos, discussões em grupo e estudos de caso. No contexto hospitalar, essas estratégias costumam ser operacionalizadas de forma articulada às demandas assistenciais e à organização do processo de trabalho, aproximando-se, em diferentes graus, dos pressupostos da EPS. Estudos realizados em hospitais de diferentes realidades institucionais e territoriais, como os hospitais comunitários da América Latina, evidenciam que tais estratégias são mais efetivas quando

adotam uma abordagem multiprofissional e consideram as especificidades dos grupos envolvidos, como as equipes de enfermagem. Além disso, a identificação prévia do perfil dos profissionais e de suas necessidades formativas mostra-se fundamental para o planejamento de ações educativas contextualizadas, capazes de favorecer maior engajamento dos trabalhadores e maior aderência das atividades ao cotidiano do cuidado (Pagotto; Varallo; Mastroianni, 2013; Zúniga *et al.*, 2024).

Segundo o estudo de Zúniga *et al.*, (2024) os profissionais em formação participaram de maneira ativa, fortalecendo o enfoque multiprofissional e integrando aliados essenciais para a vigilância, devido ao seu intenso contato com os serviços. Foram identificados diversos facilitadores para a participação nas estratégias de aprendizagem no trabalho, dentre os quais se destacam a relevância dos temas abordados e a implementação de estratégias com horários e modalidades flexíveis. Além disso, enfatizou-se a importância de disponibilizar profissionais de saúde para cobrir suas atividades e do apoio administrativo por meio de convites diretos, evidenciando a relevância do respaldo institucional no desenvolvimento de programas de EC.

Os processos formativos permanentes no campo da saúde têm como objetivo a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades que fortalecem a capacitação profissional, contribuindo para combater a perda progressiva de competências que pode ocorrer ao longo do tempo. Por outro lado, a EP fundamenta-se no humanismo, com uma preocupação genuína com a educação como uma necessidade social. Seu enfoque está no progresso e na retribuição à sociedade, promovendo um esquema de aprendizado que surge da sociedade e retorna para ela. Dessa forma, a EP integra a modalidade da EC em seu arcabouço (Ochoa; Balderas, 2021).

A educação online tornou-se uma ferramenta aliada para a formação continuada, pois oferece uma ampla gama de experiências de aprendizado e vantagens operacionais, como a flexibilidade nos horários de estudo, acesso a recursos multimídia e a possibilidade de interagir remotamente com outros profissionais e educadores de diversas áreas do conhecimento. Isso tem um impacto especial em países de baixa renda. A nova cultura de comunicação digital tende a fortalecer os laços científicos e pode contribuir para aprimorar a transparência e a reprodutibilidade das pesquisas. Além disso, o acesso amplo e rápido ao conhecimento científico em todo o mundo promete transformar positivamente a pesquisa e o ensino nos próximos anos (Ottesen *et al.*, 2021).

A EC pode ser compreendida como um conjunto de iniciativas voltadas para a

qualificação profissional, priorizando a transmissão de conhecimentos técnico-científicos com o objetivo de atualizar conceitos e práticas em conformidade com as necessidades individuais. No entanto, sua aplicação frequentemente revela-se fragmentada e desconectada da gestão e do controle social, o que compromete o alinhamento estratégico e a efetividade das mudanças institucionais que são necessárias para aprimorar os processos e os resultados no setor. A EPS por sua vez baseia-se na conexão dinâmica entre o aprendizado, o trabalho e os cuidados proporcionados nas experiências diárias dos serviços de saúde. Esse processo reforça a importância da cidadania e da ética no cuidado, exigindo o reconhecimento dessa interação e promovendo a integração de conhecimentos, habilidades, saberes e atitudes. Tudo isso está alinhado a um sistema de saúde em constante transformação, fundamentado no ciclo de ação-reflexão-ação (Brasil, 2006; Campos; Sena; Silva, 2017).

Constatou-se em alguns estudos realizados que os profissionais, em seus relatos, destacaram que os métodos de ensino utilizados nos processos formativos eram similares e aplicados por meio das mesmas estratégias pedagógicas, sem diferenciação em relação a abordagens problematizadoras. A qualificação esteve majoritariamente centrada nos aspectos cotidianos do trabalho. Além disso, os discursos dos participantes evidenciaram um desconhecimento sobre os métodos pedagógicos oferecidos pela EC e pela EPS, assim como sobre a implementação de metodologias ativas nas formações dessa última. Inferiu-se, ainda, uma lacuna significativa de informações e uma compreensão limitada sobre os propósitos associados aos métodos comumente utilizados (Oliveira *et al.*, 2024).

Na prática profissional, o enfermeiro precisa dominar conhecimentos essenciais à execução de suas funções, além de incorporar protagonismo e adotar iniciativas estratégicas vinculadas à EP. Essas necessidades surgem em resposta à complexidade e às transformações contínuas e específicas do campo da saúde. Os processos formativos, com foco na garantia da qualidade dos cuidados prestados, têm sido acompanhados por atividades educacionais que buscam sensibilizar os profissionais, promovendo reflexões e adaptações que favoreçam uma atuação mais qualificada e humanizada (Oliveira *et al.*, 2024).

Apesar dos avanços na formulação e na implementação da PNEPS, a literatura ainda apresenta lacunas importantes no que se refere à compreensão de como essas práticas se materializam no cotidiano hospitalar em contextos específicos. Embora existam estudos sobre EPS no ambiente hospitalar, observa-se uma lacuna de investigações qualitativas que analisem essas práticas a partir da perspectiva da enfermagem em hospitais localizados em regiões de tríplice fronteira, considerando as especificidades territoriais, organizacionais e

assistenciais que caracterizam esses cenários. Diante disso, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar a eficácia e a aplicabilidade dos serviços, treinamentos e capacitações ofertados por uma instituição hospitalar situada em região de tríplice fronteira. Buscou-se responder à seguinte questão de pesquisa: qual é a eficiência dos cursos de capacitação e treinamentos destinados aos profissionais de enfermagem de um hospital público localizado nessa região?

2. JUSTIFICATIVA

Segundo Costa e Lima (2023), os profissionais de enfermagem nas regiões de fronteira vivenciam particularidades que requerem conhecimentos e habilidades específicas, devido à demanda de atendimento das chamadas populações flutuantes. Esses grupos, compostos por pessoas que atravessam diariamente as fronteiras em busca de melhores condições de atendimento à saúde - como no caso do Brasil - mantêm suas residências no país de origem e não têm a intenção de se estabelecer de forma permanente em território brasileiro, motivo pelo qual não são classificados como imigrantes. Diante do exposto, os profissionais da equipe de enfermagem trabalham na linha de frente no atendimento a essas populações, sendo então a EPS essencial nesse contexto fronteiriço, para que a equipe de enfermagem possa prestar um para atendimento de boa qualidade (Berres; Baggio, 2020).

Reconhecer que a Educação pode ser uma fonte de transformação na saúde envolve aceitar que a abordagem educacional adotada pode não ser suficiente para efetivar as mudanças requeridas. Muitos profissionais da saúde, por exemplo, realizam atividades de EPS, mas isso nem sempre resulta em alterações nas práticas de cuidado (Ubessi *et al.*, 2021). Elas só serão eficazes para promover as mudanças necessárias se forem integradas a outros mecanismos, como os oferecidos pela Política Nacional de Humanização (PNH) (Brasil, 2003), em conjunto com a proposta da PNEPS (Brasil, 2007).

Como evidenciado no estudo de Aikes e Rizzotto (2018), as regiões de fronteira políticas articuladas internacionalmente para o desenvolvimento social e para a superação das assimetrias legislativas, o que reflete igualmente na EPS, pois, essa população acessa a saúde e os serviços públicos dos diferentes países, demandando assim que exista um maior financiamento de ações e serviços de saúde para a ampliação ou restrição do acesso a estrangeiros.

Nesse cenário, os processos educativos são fundamentais para o desenvolvimento de competências voltadas à segurança e à qualidade assistencial. Mais do que reforçar conhecimentos, a EPS atua como um suporte estratégico para a equipe de enfermagem, permitindo a revisão crítica das práticas e o aperfeiçoamento constante das propostas pedagógicas. Isso resulta em um ciclo de melhoria contínua, diretamente refletido na qualificação do cuidado prestado (Ramos *et al.*, 2022).

A escassez de análises qualitativas centradas na enfermagem hospitalar em regiões de fronteira reforça a relevância desta investigação. Dessa forma, uma pesquisa sobre uma

análise das práticas de EPS, justifica-se, pois, há a necessidade de se verificar as formas de avaliações e estratégias para os treinamentos e capacitações dos profissionais de enfermagem que estão intrinsecamente vinculados à qualificação da assistência e segurança dos pacientes, algo primordial no exercício do cuidado da prestação do trabalho em saúde, tendo como foco neste trabalho a enfermagem, para uma construção de propostas educativas que irão gerar uma mudança no processo de trabalho.

3. OBJETIVO

Analisar as práticas educativas do setor de Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão (NEPE) de um Hospital Público em região de fronteira, sob a perspectiva das equipes de enfermagem.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar a produção científica sobre Educação Permanente em Saúde no contexto hospitalar

Compreender a percepção dos profissionais da equipe de enfermagem sobre as práticas educativas do NEPE que participaram;

Analisar as mudanças percebidas na prática profissional que ocorreram após as formação e treinamentos na visão da equipe de enfermagem.

4. PERCURSO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE ESTUDO

O presente trabalho consiste em um estudo qualitativo, composto por duas etapas complementares: (1) revisão integrativa da literatura e (2) pesquisa empírica qualitativa com profissionais de enfermagem.

A pesquisa qualitativa, por sua essência, envolve a participação ativa do investigador, que busca entender e interpretar as informações dentro de um contexto dinâmico de interações. Os dados não são encarados como elementos isolados ou eventos estáticos observados em um único instante. Em vez disso, são considerados em sua complexidade e profundidade, refletindo questões sociais e revelando uma realidade que não pode ser mensurada. Assim, a pesquisa qualitativa explora um amplo universo de significados e um espaço profundo de interações e fenômenos (Minayo, 2014).

4.2 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

A revisão integrativa da literatura foi realizada com o objetivo de analisar a produção científica acerca das práticas de Educação Permanente em Saúde no contexto hospitalar. Para a formulação da questão de pesquisa, utilizou-se a estratégia PVO (*Patient, Variable, Outcomes*), por seu caráter exploratório e por auxiliar na identificação de palavras-chave relevantes. O componente P correspondeu aos enfermeiros de serviços hospitalares; o V referiu-se à educação permanente em saúde enquanto instrumento e estratégia de gestão; e o O relacionou-se à melhoria da gestão e da qualidade da assistência nos serviços hospitalares. Dessa forma, a questão de pesquisa foi delimitada como: “Como a educação permanente em saúde, enquanto instrumento e estratégia de gestão, contribui para a melhoria da gestão hospitalar e da qualidade da assistência na atuação de enfermeiros”.

A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e LILACS, utilizando descritores controlados e não controlados relacionados à temática, combinados por operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, considerando esse período como relevante em razão do contexto da pandemia de covid-19; estudos que abordassem a educação permanente no contexto da gestão hospitalar;

publicações disponíveis na íntegra e de acesso gratuito; artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos estudos duplicados entre as bases, artigos que não respondiam à questão de pesquisa, publicações do tipo editoriais, cartas ao editor, resumos de eventos, dissertações, teses e revisões de literatura.

A triagem dos estudos ocorreu com o auxílio do software *Rayyan*, ferramenta utilizada para a organização e o processo de seleção de artigos em revisões de literatura. A seleção dos estudos foi conduzida por dois revisores independentes, a partir da leitura dos títulos e resumos, com exclusão das publicações duplicadas e daquelas que não atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. As eventuais divergências entre os revisores foram resolvidas por consenso.

Posteriormente, os estudos pré-selecionados foram submetidos à leitura na íntegra, sendo avaliados quanto à adequação metodológica, à pertinência em relação ao objetivo do estudo e à relevância do conteúdo. Ao final desse processo, foram definidos os artigos que compuseram a amostra da revisão integrativa.

A organização e apresentação dos resultados seguiram as recomendações do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), de forma adaptada à revisão integrativa, sendo utilizado exclusivamente para descrever de maneira clara e sistematizada o processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos. Ressalta-se que o instrumento foi empregado apenas como estratégia de organização visual e apresentação dos resultados, não se caracterizando como protocolo metodológico de revisão sistemática.

Conforme preconizado por Mendes, Silveira e Galvão⁽¹⁴⁾, o nível de evidência dos estudos deve ser avaliado com o objetivo de determinar a confiabilidade dos resultados apresentados e fortalecer as conclusões que compõem o estado atual do conhecimento sobre o tema investigado. Dessa forma, os estudos incluídos nesta revisão tiveram seus níveis de evidência analisados de acordo com a classificação proposta por Melnyk e Fineout-Overholt⁽¹⁵⁾, a qual compreende: nível I, evidências provenientes de revisões sistemáticas ou meta-análises de ensaios clínicos randomizados; nível II, evidências obtidas a partir de ensaios clínicos randomizados individuais; nível III, evidências oriundas de ensaios clínicos controlados sem randomização; nível IV, evidências provenientes de estudos de coorte ou caso-controle; nível V, evidências derivadas de revisões sistemáticas de estudos qualitativos ou descritivos; nível VI, evidências oriundas de estudos qualitativos ou descritivos; e nível VII, evidências baseadas na opinião de especialistas ou relatórios de comitês de especialistas.

Por fim, os dados extraídos dos estudos selecionados foram interpretados e sintetizados, permitindo a elaboração de conclusões fundamentadas na integração dos diferentes conceitos identificados. A análise dos dados ocorreu por meio de análise temática, possibilitando a organização dos achados em dois núcleos centrais, definidos a partir da questão norteadora do estudo: educação permanente como ferramenta para o desenvolvimento de competências gerenciais e impacto da educação permanente na qualidade da assistência e no atendimento ao paciente.

4.3 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO NEPE

Esta etapa, de abordagem qualitativa, busca explorar e compreender os sentidos que os indivíduos ou grupos atribuem a problemas sociais ou humanos. Serão utilizadas as orientações do *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research* (COREQ).

4.3.1 Local de Estudo

A pesquisa foi realizada no setor do NEPE do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL). O HMPGL está localizado em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A primeira fase de sua construção, assim como a inauguração inicial, foi concluída em setembro de 2006. Sua gestão ocorre em parceria entre o município de Foz do Iguaçu e o Governo do Estado do Paraná, e suas atividades são sustentadas por um projeto colaborativo envolvendo Município, Estado e União. Administrado pela Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, o hospital recebe recursos provenientes dos três níveis de governo para sua manutenção e expansão. A inauguração oficial aconteceu em 10 de junho de 2011. Integrando a rede de saúde vinculada ao SUS, o HMPGL é gerido pela Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (HMPGL, 2020).

A instituição consolida-se como o principal polo de saúde do extremo oeste paranaense, sendo responsável pelo atendimento dos nove municípios que integram a 9ª Regional de Saúde. Sua relevância estende-se à Tríplice Fronteira, onde atua como referência para brasileiros, paraguaios e argentinos, além de absorver a demanda de urgência e trauma do fluxo turístico internacional (HMPGL, 2020).

O NEPE do HMPGL foi criado com o propósito de implementar estratégias de educação contínua para os funcionários, visando manter uma equipe capacitada para

solucionar problemas e promover melhorias no processo de trabalho. É um setor dedicado à atualização contínua na área da saúde, que conta com uma equipe multiprofissional e tem como objetivo qualificar os colaboradores em diversos temas pertinentes à saúde, garantindo assim um atendimento eficaz. Este núcleo se configura como um ambiente de aprendizado constante, onde a formação dos colaboradores é fundamental para assegurar o cumprimento rigoroso dos protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes e pelas normativas de saúde permanente (HMPGL, 2020).

4.4 DESENHO DO ESTUDO

4.4.1 Participantes e critérios de inclusão e exclusão

Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na instituição. Os critérios de inclusão são profissionais com vínculo efetivo na instituição hospitalar do estudo e que atuem nos serviços há mais de seis meses e que já tenham participado das atividades do NEPE. Os critérios de exclusão são profissionais que estejam de férias ou afastados no período de coleta de dados.

4.4.2 Coleta de dados

Os dados qualitativos foram coletados por meio de entrevistas com os profissionais da equipe de enfermagem dos turnos vespertino, matutino e noturno. Para isso, foi utilizado um roteiro semiestruturado elaborado pelos pesquisadores deste estudo, contendo perguntas relacionadas à experiência dos profissionais com o programa de EP da instituição. Para a definição da população a ser estudada, adotou-se uma amostra do tipo proposital e intencional (Turato, 2003). O estudo não teve como objetivo a saturação teórica clássica, mas a compreensão aprofundada de diferentes perfis profissionais em um contexto específico de fronteira, priorizando diversidade de experiências.

Foi realizado um convite à equipe de enfermagem para participar das entrevistas, por meio de um informe elaborado em conjunto com a coordenação de enfermagem e o setor do NEPE. As entrevistas ocorreram em local apropriado, nas dependências do HMPGL, garantindo um ambiente reservado, sem interrupções durante o processo de coleta, de modo a assegurar a privacidade e o conforto dos profissionais participantes. As entrevistas foram

conduzidas por uma pesquisadora vinculada ao próprio hospital com formação em pedagogia e experiência prévia no campo. Por reconhecer o potencial de assimetria de poder e viés de desejabilidade social, foram adotadas medidas para minimizar interferências, como garantia à local reservado, reforçar que não haveria prejuízo profissional e assegurar anonimato.

O instrumento de coleta de dados consta no Apêndice 1, é constituído por um roteiro semiestruturado dividido em duas partes: a primeira refere-se à identificação e a caracterização sociodemográfica dos enfermeiros e técnicos; a segunda composta por questões abertas, com a análise das atividades de EPS do HMPGL e sua relação com a prática assistencial.

O conteúdo das entrevistas foi gravado em áudio, transcrito por meio do aplicativo Riverside® e posteriormente revisado para assegurar a fidelidade das transcrições. Em seguida, o material foi devolvido aos participantes para que pudessem realizar comentários ou correções. As entrevistas foram conduzidas individualmente, e o roteiro utilizado foi previamente testado por meio de uma entrevista piloto, sendo ajustado quando necessário.

O contato com os participantes para conferência das transcrições ocorreu por e-mail ou WhatsApp®. Após o envio, foi concedido um prazo de uma semana para validação. Caso não houvesse manifestação após o prazo, a transcrição foi mantida na análise dos dados.

4.4.3 Análise dos dados

Segundo Minayo (2001), toda investigação científica tem como ponto de partida a formulação de um problema, geralmente expressado por meio de uma dúvida ou pergunta. Essa indagação se articula com conhecimentos previamente construídos, podendo demandar a elaboração de novos referenciais teóricos que emergem do próprio objeto de estudo, à medida que o conhecimento se expande por meio da pesquisa. A teoria, nesse contexto, representa um corpo de saberes sistematizados por outros pesquisadores, que contribui para a compreensão da questão investigada e orienta novas construções conceituais. Seu propósito é explicar ou interpretar fenômenos, processos ou conjuntos de ambos. A partir dessa base, o pesquisador realiza um trabalho rigoroso de seleção e delimitação de aspectos significativos da realidade, buscando estabelecer interconexões sistemáticas entre eles. Contudo, nenhuma teoria, por mais robusta que seja, é capaz de abarcar a totalidade dos fenômenos e processos sociais, o que justifica a necessidade contínua de novas investigações.

Compreende-se, portanto, que a condução de uma pesquisa exige não apenas

determinadas competências pessoais do pesquisador, mas também um planejamento metodológico rigoroso. Entre as etapas mais relevantes desse processo, destaca-se a definição precisa das técnicas de coleta e análise de dados, fundamentais para permitir a exploração aprofundada e sistemática das informações obtidas. Segundo Oliveira *et al.* (2020), a escolha dessas técnicas deve estar alinhada aos objetivos da investigação e à natureza do fenômeno estudado, de modo a assegurar a consistência, a validade e a confiabilidade dos resultados.

A técnica de Análise de Conteúdo, segundo Minayo (2001), é compreendida como um conjunto de procedimentos originados nos Estados Unidos no início do século XX, inicialmente marcado por uma abordagem quantitativa centrada na frequência de elementos nas mensagens. Atualmente, essa técnica assume duas funções principais: a confirmação de hipóteses previamente formuladas e a descoberta de significados ocultos nos conteúdos manifestos, podendo ser aplicada tanto em pesquisas quantitativas quanto qualitativas. O processo analítico se desenvolve em três fases: na primeira, organiza-se o material conforme os objetivos do estudo, definindo unidades de registro, contexto, trechos significativos e categorias; na segunda, considerada a mais extensa, os dados são explorados e codificados, agrupando informações com características semelhantes; por fim, na terceira fase, realiza-se o tratamento e interpretação dos resultados, com uso de estatísticas simples e elaboração de tabelas que sintetizam os dados, permitindo inferências e revelando sentidos subjacentes aos documentos analisados.

Dessa forma, o objeto de estudo deste projeto refere-se aos conceitos e às etapas da Análise de Conteúdo, uma técnica metodológica amplamente empregada em pesquisas científicas de abordagem qualitativa. Tal método contribui significativamente para a identificação e a compreensão dos significados subjacentes aos textos analisados, permitindo uma interpretação mais aprofundada e abrangente das informações, ao considerar a pluralidade de sentidos presentes nos dados coletados.

4.4.4 Aspectos éticos e legais

Os dados da pesquisa foram coletados somente após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Oeste do Paraná – UNIOESTE e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme consta no Apêndice 2. Além disso, foram seguidas as orientações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que regulamentam as pesquisas envolvendo seres humanos

(Brasil, 2012). O estudo atendeu às exigências éticas, obtendo aprovação do Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (CAAE: 88991625.7.0000.0107) e da instituição hospitalar.

5. RESULTADOS

A revisão integrativa da literatura permitiu identificar os principais eixos temáticos relacionados à Educação Permanente em Saúde no contexto hospitalar, os quais subsidiaram a construção do roteiro de entrevistas e a interpretação dos dados empíricos. Os resultados dessa etapa são apresentados a seguir no Artigo 1.

A aplicação dos questionários junto aos profissionais de enfermagem permitiu identificar categorias que expressam a percepção da equipe acerca da EPS. As respostas foram agrupadas em eixos temáticos, favorecendo a compreensão dos aspectos mais valorizados e dos obstáculos relatados pelos participantes. Embora alguns desafios sejam comuns ao contexto hospitalar, na tríplice fronteira eles são intensificados pela flutuação populacional, diversidade cultural e imprevisibilidade da demanda assistencial, o que impacta diretamente a organização da EPS.

Concluída a análise e interpretação das categorias, optou-se por organizar os resultados em formato de artigo científico, submetido à Revista Ideação (Qualis A2). O texto completo é apresentado na sequência, em consonância com as normas editoriais do periódico.

ARTIGO 1: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR: REVISÃO INTEGRATIVA

Juliana Marçal
Flávia Shimeny Soares Cardoso
Luciana Aparecida Fabriz
Thais Fernanda Tortorelli Zarili

RESUMO

Objetivo: analisar criticamente as evidências científicas acerca da influência da Educação Permanente em Saúde (EPS), enquanto estratégia de gestão, na qualificação da assistência e no desempenho gerencial em serviços hospitalares. **Métodos:** Revisão integrativa da literatura conduzida nas bases PubMed e LILACS, utilizando descritores controlados (MeSH e DeCS) relacionados à gestão hospitalar, educação permanente e enfermagem, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos originais, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após identificação de 1.269 registros, aplicação de critérios de elegibilidade e análise por dois revisores independentes, sete estudos compuseram a amostra final. O nível de evidência foi classificado segundo Melnyk e Fineout-Overholt, e os achados foram organizados por análise temática. **Resultados:** Observou-se predominância de estudos qualitativos e de métodos mistos (nível VI), além de delineamentos quase-experimentais (nível III). As evidências indicam que a EPS contribui para o desenvolvimento de competências gerenciais, fortalecimento da liderança colaborativa, melhoria da comunicação organizacional e qualificação da tomada de decisão em contextos hospitalares. Intervenções educativas estruturadas demonstraram impacto positivo no desempenho profissional, na segurança assistencial e na capacidade de enfrentamento de situações críticas. Entretanto, a escassez de estudos com delineamentos experimentais robustos limita inferências causais sobre seus efeitos organizacionais. **Conclusão:** A EPS configura-se como estratégia relevante para a qualificação da gestão hospitalar e da assistência, especialmente no fortalecimento de competências gerenciais da enfermagem. Contudo, a consolidação de sua efetividade exige maior investimento institucional e produção de evidências com maior rigor metodológico, capazes de sustentar sua incorporação como política estruturante no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Administração de Serviços de Saúde; Enfermagem; Educação Permanente em Saúde; Gestão Hospitalar; Qualidade da Assistência à Saúde.

ABSTRACT

Objective: To critically analyze the scientific evidence regarding the influence of Permanent Health Education (PHE), as a management strategy, on the qualification of care and managerial performance in hospital services. **Methods:** An integrative literature review was conducted in the PubMed and LILACS databases, using controlled descriptors (MeSH and DeCS) related to hospital management, permanent education, and nursing, combined with Boolean operators. Original articles available in full text in Portuguese, English, and Spanish were included. After identifying 1,269 records, applying eligibility criteria, and conducting independent screening by two reviewers, seven studies comprised the final sample. The level of evidence was classified according to Melnyk and Fineout-Overholt, and findings were

organized through thematic analysis. Results: A predominance of qualitative and mixed-methods studies (Level VI) was observed, along with quasi-experimental designs (Level III). Evidence indicates that PHE contributes to the development of managerial competencies, strengthening of collaborative leadership, improvement of organizational communication, and enhancement of decision-making processes in hospital settings. Structured educational interventions demonstrated a positive impact on professional performance, patient safety, and the ability to manage critical situations. However, the scarcity of studies with robust experimental designs limits causal inferences regarding organizational outcomes. Conclusion: PHE emerges as a relevant strategy for improving hospital management and quality of care, particularly in strengthening nursing managerial competencies. Nevertheless, consolidating its effectiveness requires greater institutional investment and the production of methodologically rigorous evidence to support its incorporation as a structuring policy within hospital environments.

Keywords: Health Services Administration; Nursing; Permanent Health Education; Hospital Management; Quality of Health Care.

INTRODUÇÃO

A Educação Permanente em Saúde (EPS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), adquire centralidade a partir da instituição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, estabelecida pela Portaria nº 198/GM, de 2004, que define diretrizes para a formação contínua dos trabalhadores da saúde.⁽¹⁾ Essa política acompanha a própria evolução do SUS e propõe uma gestão do conhecimento baseada na problematização do processo de trabalho, na troca de saberes e na participação coletiva, contribuindo para uma gestão compartilhada das ações e serviços de saúde, mesmo diante de desafios como o subfinanciamento e a precarização das condições de trabalho no setor.⁽²⁾

O marco regulatório instituído pela Constituição Federal de 1988,⁽³⁾ especialmente por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990⁽⁴⁾, foi fundamental para a consolidação do SUS, ao definir responsabilidades e promover a cooperação entre os diferentes níveis de governo. A incorporação da qualificação profissional como elemento estruturante das políticas públicas possibilitou avanços significativos na formação dos trabalhadores da saúde, fortalecendo práticas alinhadas aos princípios do sistema⁽⁵⁾.

A criação do SUS e a adoção de seus princípios (universalidade, integralidade e equidade), provocaram mudanças expressivas na formação dos profissionais de saúde no Brasil, ampliando a compreensão do processo saúde-doença e reconhecendo novas abordagens de cuidado. Esse contexto demandou a reorganização das práticas profissionais, com maior integração e atuação intersetorial, especialmente diante de modelos formativos historicamente dissociados das diretrizes do SUS, como a integralidade do cuidado⁽⁶⁾.

No âmbito da Enfermagem, essas transformações evidenciam lacunas importantes, sobretudo na formação de liderança e no desenvolvimento de competências gerenciais. Muitos enfermeiros assumem funções de gestão hospitalar fundamentados predominantemente em sua experiência clínica, sem o suporte institucional necessário para o fortalecimento de habilidades relacionadas à liderança, planejamento e tomada de decisão. Tal cenário reforça a necessidade de programas estruturados de desenvolvimento gerencial, capazes de preparar esses profissionais para conduzir equipes e enfrentar a complexidade dos serviços de saúde contemporâneos⁽⁷⁾.

Nesse contexto, a educação continuada e a educação permanente em saúde configuram-se como estratégias essenciais para o desenvolvimento de competências gerenciais na gestão hospitalar, uma vez que promovem a qualificação dos profissionais a partir das necessidades do processo de trabalho. Essas práticas contribuem para o aprimoramento de conhecimentos técnicos, habilidades administrativas e de liderança, favorecendo a organização dos serviços, a coordenação das equipes e a melhoria da qualidade da assistência⁽⁸⁾.

Conforme aponta Bardella⁽⁹⁾, a educação permanente contribui para o enfrentamento de desafios relacionados à gestão de recursos humanos, à resolução de conflitos e à tomada de decisões estratégicas, promovendo ambientes de trabalho mais organizados, eficientes e alinhados às mudanças tecnológicas e às exigências regulatórias.

Entretanto, para que a educação continuada e a EPS produzam impactos efetivos na prática profissional, é necessário que sejam planejadas de forma descentralizada, coletiva e integrada aos instrumentos de gestão, respeitando as especificidades dos diferentes contextos de trabalho. Apesar de seu potencial transformador, a implementação da EPS ainda enfrenta obstáculos, especialmente relacionados à limitação de conhecimentos sobre estratégias e métodos eficazes para seu planejamento e execução nos serviços de saúde⁽⁵⁾.

A gestão da EPS no ambiente hospitalar pressupõe uma interação contínua entre gestores, profissionais de saúde e usuários, favorecendo a construção coletiva do conhecimento e a revisão crítica das práticas assistenciais. A qualificação permanente contribui para o fortalecimento das habilidades profissionais, melhora a comunicação entre as equipes e reduz falhas que podem comprometer a segurança e a qualidade do cuidado prestado ao paciente⁽¹⁰⁾.

Nessa perspectiva, a EPS caracteriza-se como uma prática reflexiva e dialógica, construída a partir das dinâmicas do trabalho e voltada à participação ativa dos profissionais

no processo de ensino-aprendizagem. Ao estimular o pensamento crítico e o protagonismo dos trabalhadores, a EPS fortalece a governança em saúde, promove o empoderamento dos gestores e favorece a adoção de práticas inovadoras que qualificam os serviços prestados⁽⁵⁾.

Além disso, a EPS apresenta elevado potencial para o desenvolvimento de uma gestão estratégica nos hospitais, ao incentivar o acompanhamento de metas, indicadores de capacitação e processos avaliativos. Esse movimento possibilita que os profissionais atuem como agentes de transformação, promovendo ambientes de autogestão, corresponsabilidade e aprendizagem colaborativa, fundamentais para enfrentar os desafios dinâmicos do setor hospitalar⁽¹¹⁾.

Segundo Sardinha *et al.*⁽¹²⁾, a proposta da EPS abrange múltiplas esferas, envolvendo gestão, serviços de saúde, instituições formadoras e instâncias de controle social. Fundamentada em uma pedagogia problematizadora, essa abordagem busca transformar práticas técnicas e sociais, promover mudanças institucionais, fortalecer equipes de trabalho e qualificar continuamente a assistência à saúde.

Embora frequentemente utilizados como sinônimos, os conceitos de EPS, educação continuada e treinamento apresentam distinções epistemológicas e operacionais. A EPS configura-se como estratégia político-pedagógico integrada ao processo de trabalho, orientada à transformação institucional e à construção coletiva do conhecimento. Já a educação continuada refere-se à atualização sistemática de competências profissionais, enquanto o treinamento caracteriza-se como intervenção pontual voltada ao desenvolvimento de habilidades específicas. A distinção entre esses conceitos é fundamental para evitar reducionismos que instrumentalizem a EPS como mera capacitação técnica^(1, 12-14).

Dessa forma, a EPS no contexto hospitalar consolida-se como uma estratégia essencial para a renovação das práticas de atenção, gestão e controle social. Ao valorizar os saberes prévios dos profissionais e incentivar sua atualização contínua, a EPS também estimula a produção de pesquisas na interface entre educação e saúde, contribuindo para o aprimoramento permanente das práticas no ambiente hospitalar⁽¹¹⁾.

Apesar da consolidação normativa da EPS no SUS, observa-se escassez de sínteses críticas que analisem especificamente sua interface com a gestão hospitalar e seus impactos na qualidade da assistência, especialmente sob a perspectiva da atuação de enfermeiros gestores

Diante desse cenário, realizou-se uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de analisar as evidências científicas sobre a influência da educação permanente em saúde, enquanto instrumento e estratégia de gestão, na qualidade da assistência e na eficácia da

gestão em serviços hospitalares. Essa abordagem buscou sintetizar o conhecimento produzido sobre a temática, contribuindo para o fortalecimento da gestão hospitalar e para a qualificação da prática profissional da Enfermagem.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, escolhida por possibilitar a síntese de resultados de pesquisas com diferentes delineamentos metodológicos, contribuindo para a compreensão ampliada de fenômenos complexos relacionados ao cuidado e à gestão em saúde, além de identificar lacunas do conhecimento científico que podem subsidiar novos estudos. Esse método permite integrar evidências científicas para discutir conceitos, teorias e práticas relacionadas a temática⁽¹⁵⁾.

A revisão integrativa foi conduzida conforme as etapas propostas por Mendes, Silveira e Galvão⁽¹⁶⁾, sendo: (1) identificação do tema e definição da hipótese ou da questão de pesquisa; (2) estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos e realização da busca na literatura; (3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos mesmos; (4) avaliação crítica dos estudos incluídos na revisão integrativa; (5) interpretação dos resultados; e (6) apresentação da revisão e síntese do conhecimento produzido.

Para a formulação da questão de pesquisa, utilizou-se a estratégia PVO (*Patient, Variable, Outcomes*), por seu caráter exploratório e por auxiliar na identificação de palavras-chave relevantes. O componente P correspondeu aos enfermeiros de serviços hospitalares; o V referiu-se à educação permanente em saúde enquanto instrumento e estratégia de gestão; e o O relacionou-se à melhoria da gestão e da qualidade da assistência nos serviços hospitalares. Dessa forma, a questão de pesquisa foi delimitada como: “Como a educação permanente em saúde, enquanto instrumento e estratégia de gestão, contribui para a melhoria da gestão hospitalar e da qualidade da assistência na atuação de enfermeiros”.

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados eletrônicas *Public Medline* (PubMed) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), selecionadas por sua relevância na indexação de produções científicas na área da saúde e da Enfermagem. Foram utilizados descritores controlados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e dos *Medical Subject Headings* (MeSH), combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Chaves de busca aplicadas às bases de dados eletrônicas

BASE DE DADOS	CHAVE DE BUSCA
PubMed	("hospital administration"[mh] OR "hospitals"[tw] OR "hospital"[tw]) AND ("organization and administration"[mh] OR "administration"[tw] OR "organizations"[tw] OR "organization"[tw]) AND ("education, continuing"[mh] OR "education"[tw] OR "educational status"[tw]) AND ("continuing"[mh] OR "education"[tw] OR "educational status"[tw]) AND ("hospital departments"[mh] OR "department, hospital"[tw])
LILACS	((mh:("hospital administration") OR tw:("hospitals" OR "hospital")) AND (mh: ("organization and administration") OR tw:("administration" OR "organizations" OR "organization"))) AND (mh:("education, continuing") OR tw:("education" OR "educational status")) AND (mh:("continuing") OR tw:("education" OR "educational status")) AND (mh:("hospital departments") OR tw:("department, hospital")))

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

Os critérios de inclusão definidos foram: artigos científicos publicados a partir de 2020, considerando esse período como relevante em razão do contexto da pandemia de covid-19; estudos que abordassem a educação permanente no contexto da gestão hospitalar; publicações disponíveis na íntegra e de acesso gratuito; artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos estudos duplicados entre as bases, artigos que não respondiam à questão de pesquisa, publicações do tipo editoriais, cartas ao editor, resumos de eventos, dissertações, teses e revisões de literatura.

A primeira coleta de dados foi realizada em outubro de 2024, e a busca foi atualizada em janeiro de 2026. A triagem dos estudos ocorreu com o auxílio do software *Rayyan*, ferramenta utilizada para a organização e o processo de seleção de artigos em revisões de literatura. A seleção dos estudos foi conduzida por dois revisores independentes, a partir da leitura dos títulos e resumos, com exclusão das publicações duplicadas e daquelas que não atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. As eventuais divergências entre os revisores foram resolvidas por consenso.

Posteriormente, os estudos pré-selecionados foram submetidos à leitura na íntegra, sendo avaliados quanto à adequação metodológica, à pertinência em relação ao objetivo do estudo e à relevância do conteúdo. Ao final desse processo, foram definidos os artigos que compuseram a amostra da revisão integrativa.

A organização e apresentação dos resultados seguiram as recomendações do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), de forma adaptada à revisão integrativa, sendo utilizado exclusivamente para descrever de maneira clara e

sistematizada o processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos. Ressalta-se que o instrumento foi empregado apenas como estratégia de organização visual e apresentação dos resultados, não se caracterizando como protocolo metodológico de revisão sistemática.

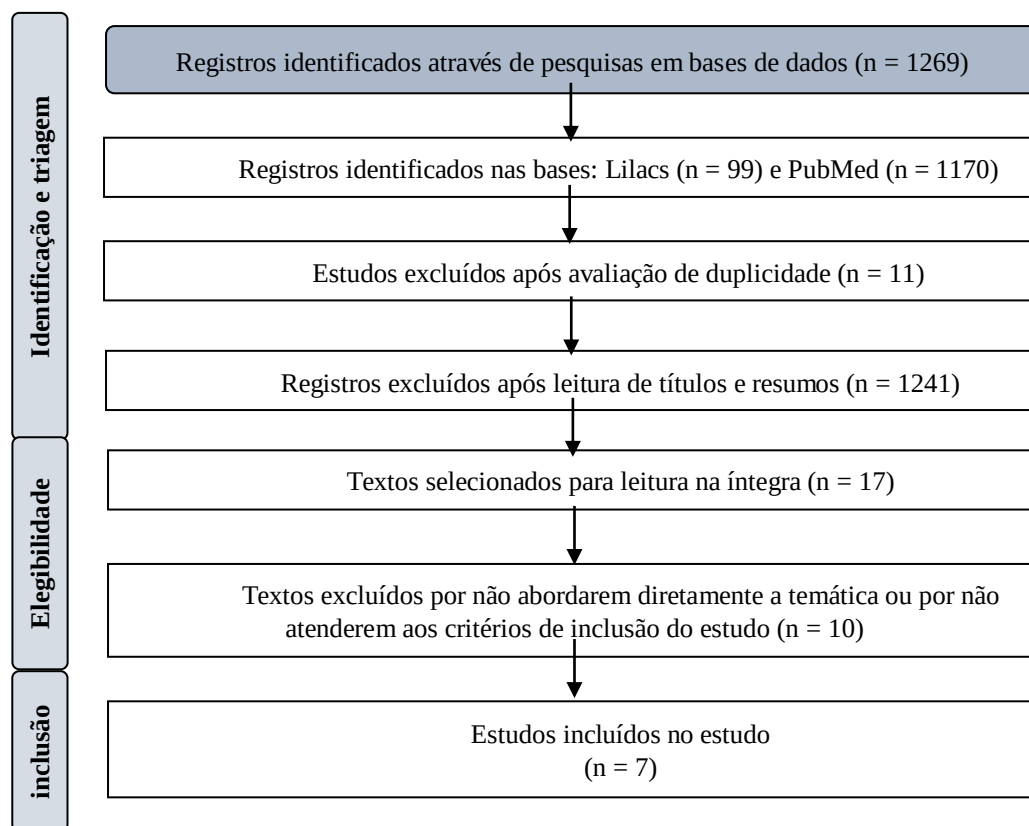
Conforme preconizado por Mendes, Silveira e Galvão⁽¹⁶⁾, o nível de evidência dos estudos deve ser avaliado com o objetivo de determinar a confiabilidade dos resultados apresentados e fortalecer as conclusões que compõem o estado atual do conhecimento sobre o tema investigado. Dessa forma, os estudos incluídos nesta revisão tiveram seus níveis de evidência analisados de acordo com a classificação proposta por Melnyk e Fineout-Overholt⁽¹⁷⁾, a qual compreende: nível I, evidências provenientes de revisões sistemáticas ou meta-análises de ensaios clínicos randomizados; nível II, evidências obtidas a partir de ensaios clínicos randomizados individuais; nível III, evidências oriundas de ensaios clínicos controlados sem randomização; nível IV, evidências provenientes de estudos de coorte ou caso-controle; nível V, evidências derivadas de revisões sistemáticas de estudos qualitativos ou descritivos; nível VI, evidências oriundas de estudos qualitativos ou descritivos; e nível VII, evidências baseadas na opinião de especialistas ou relatórios de comitês de especialistas.

Por fim, os dados extraídos dos estudos selecionados foram interpretados e sintetizados, permitindo a elaboração de conclusões fundamentadas na integração dos diferentes conceitos identificados. A análise dos dados ocorreu por meio de análise temática, possibilitando a organização dos achados em dois núcleos centrais, definidos a partir da questão norteadora do estudo: educação permanente como ferramenta para o desenvolvimento de competências gerenciais e impacto da educação permanente na qualidade da assistência e no atendimento ao paciente.

RESULTADOS

A pesquisa nas bases de dados resultou em 1269 estudos identificados, dos quais 1170 foram oriundos da base PubMed e 99 da base Lilacs. Após as etapas de refinamento, 17 publicações permaneceram para análise do conteúdo completo. Dentre essas, sete estudos atenderam aos objetivos da revisão e constituíram a amostra final analisada. A distribuição dos estudos ao longo das etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão encontra-se apresentada na Figura 1, por meio de um fluxograma baseado no modelo PRISMA adaptado.

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos segundo o PRISMA adaptado



Fonte: Elaborado pelas autoras, com base no PRISMA (2020)

As publicações incluídas na revisão foram predominantemente redigidas em língua inglesa, correspondendo a 57,14% do total, enquanto os estudos em português representaram 42,86% da amostra. Não foram identificadas publicações em língua espanhola. Quanto ao período de publicação, observou-se a distribuição de um artigo publicado em 2024, dois em 2023, dois em 2022 e dois em 2020, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa

Autores	Título	Ano/País	Delineamento /Amostra	Principais resultados	NE¹
Wilson; Varcoe; Wathen ⁽¹⁶⁾	Beyond Education: What is required to support staff to promote equity-oriented health	2024 Canadá	Estudo de métodos mistos (mixed-methods), com aplicação de pesquisas e entrevistas qualitativas.	O estudo revelou altos níveis de estresse entre funcionários de departamentos de emergência no Canadá, associados a falta de controle sobre	VI

¹ Nível de evidência, conforme classificação de Melnyk e Fineout-Overholt (2023).

	care in EDs?		N = 393 profissionais de três departamentos de emergência.	o trabalho, insuficiência de tempo e treinamento limitado para cuidados orientados à equidade.	
Zagalioti <i>et al</i> ⁽¹⁷⁾	The first positive evidence that training improves triage decisions in Greece: evidence from emergency nurses at an Academic Tertiary Care Emergency Department.	2023 Grécia	Ensaio clínico controlado sem randomização (quase-experimental) do tipo pré- e pós-teste em um único grupo, sem grupo controle paralelo. N = 36 enfermeiros de emergência.	O treinamento de 45 minutos por <i>e-learning</i> melhorou significativamente a competência em triagem dos enfermeiros, com aumento no número de respostas corretas no pós-teste.	III
Ferreira; Ba lsanelli; Sa ntos ⁽¹⁸⁾	Competências profissionais dos enfermeiros de unidades de urgência e emergência: estudo de método misto.	2023 Brasil	Estudo de métodos mistos, com design sequencial explanatório, que combinou dados quantitativos e qualitativos. N = 39 enfermeiros participaram da etapa quantitativa, enquanto 17 participaram da etapa qualitativa.	A falta de educação permanente e treinamentos práticos foi identificada como um problema, levando os profissionais a buscarem capacitação de forma individual. Melhorias sugeridas incluem o fortalecimento de núcleos de educação permanente e investimentos em recursos para treinamentos.	VI
Zinn <i>et al</i>	Educação permanente em saúde como prática possível: uma experiência na atenção primária.	2022 Brasil	Pesquisa-ação com abordagem mista. N = Na etapa inicial, 11 profissionais de saúde (enfermeiros e técnicos), e na etapa final, 125 profissionais.	O tema prioritário identificado foi a comunicação prejudicada no ambiente de trabalho. A implementação do programa educativo gerou acordos para melhorar a comunicação, como organização de murais, fluxos definidos e criação de espaços de diálogo.	VI
Silva <i>et</i>	Política	2022	Estudo de caso	Os participantes	VI

<i>al</i> ⁽¹⁹⁾	Nacional de Educação Permanente em Saúde: aspectos que compõem o perfil dos profissionais que atuam nas Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES) Regionais no Pará.	Brasil	exploratório com análise qualitativa. N = 25 profissionais que atuam em 13 Centros Regionais de Saúde do Pará.	atribuíram alta importância ao funcionamento das CIES (96%). O estudo identificou desafios, como rotatividade de profissionais, limitações no financiamento e dificuldades de regionalização, que impactam a consolidação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS).	
Lam <i>et al</i> ⁽²⁰⁾	Investigating the Strategies Adopted by Emergency Nurses to Address Uncertainty and Change in the Event of Emerging Infectious Diseases: A Grounded Theory Study.	2020 Hong Kong	Estudo qualitativo utilizando a teoria fundamentada no modelo de Strauss, baseado em entrevistas semiestruturadas. N = 26 enfermeiros de emergência.	Enfermeiros de emergência utilizam estratégias como avaliação abrangente, educação continuada, adaptação a diretrizes atualizadas e navegação de novas competências para lidar com incertezas e mudanças durante epidemias.	VI
Zhang <i>et al</i> ⁽²¹⁾	Impact of death education courses on emergency nurses' perception of effective behavioral responses in dealing with sudden death in China: A quasi-experimental study	2020 China	Quase-experimental do tipo pré e pós-teste em um único grupo (antes da intervenção e 6 semanas após), sem grupo controle. N = 34 enfermeiros de emergência.	O curso de 20 horas, baseado em um modelo para lidar com mortes súbitas, melhorou significativamente a percepção dos enfermeiros sobre respostas comportamentais eficazes. Após a intervenção, os enfermeiros relataram maior capacidade de informar e apoiar famílias em luto, além de respeitar costumes e fornecer informações práticas.	III

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026)

A análise dos níveis de evidência dos artigos incluídos demonstra o predomínio de estudos classificados como Nível VI, evidenciando que a produção científica sobre educação permanente em saúde tem se concentrado principalmente em abordagens descritivas, qualitativas e de métodos mistos. Esses delineamentos são apropriados para explorar fenômenos complexos, como percepções, experiências profissionais, organização do trabalho e processos formativos, favorecendo uma compreensão aprofundada do contexto estudado.

Entretanto, a predominância desse nível de evidência indica limitações quanto à força inferencial dos achados, uma vez que esses estudos não permitem estabelecer relações causais nem mensurar de forma robusta o impacto das intervenções educativas.

Em contrapartida, os estudos classificados como Nível III representam um avanço ao avaliarem intervenções educativas por meio de delineamentos quase-experimentais, apontando efeitos positivos na capacitação e no desempenho dos enfermeiros. Ainda assim, a ausência de randomização e de grupos controle reforça a necessidade de cautela na interpretação dos resultados, evidenciando a necessidade de estudos futuros com delineamentos mais robustos.

DISCUSSÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS NO CONTEXTO HOSPITALAR

A EPS ainda apresenta reconhecimento desigual entre instituições e regiões, contudo evidencia-se como uma estratégia com elevado potencial para o desenvolvimento de competências gerenciais no contexto hospitalar. Embora as competências profissionais dos enfermeiros sejam continuamente atualizadas, esse processo exige inovação constante diante das transformações organizacionais e tecnológicas da área da saúde. Ademais, a atuação gerencial ultrapassa os limites dos treinamentos formais, sendo fortemente influenciada pela vivência prática, pela experiência acumulada e pelo tempo de atuação nos serviços¹⁸.

Nesse sentido, Silva *et al.*⁽¹⁹⁾, destacam que a efetivação da EPS demanda a adoção de metodologias ativas, sustentadas por um processo reflexivo e contínuo, elementos fundamentais para o fortalecimento das capacidades gerenciais. A abordagem integrada da EPS, ao articular ensino, serviço e gestão, favorece a preparação dos profissionais para liderar mudanças organizacionais, aprimorar processos de trabalho e alcançar resultados mais

efetivos, especialmente em contextos que exigem articulação intersetorial e tomada de decisão compartilhada.

Sob a perspectiva da gestão hospitalar, a implementação da EPS impõe desafios relevantes, como o desenvolvimento de profissionais de maneira participativa e permanente, estimulando o engajamento ativo no processo educativo. A EPS perpassa as diferentes dimensões do cuidado e da gestão, exigindo ajustes estratégicos e organizacionais capazes de potencializar o desempenho individual e coletivo. Dessa forma, consolida-se como uma ferramenta estratégica para o fortalecimento das equipes e para a melhoria da eficácia organizacional nos serviços de saúde⁽²⁰⁾.

Corroborando essa perspectiva, Zinn *et al.*⁽²⁰⁾ evidenciam que programas educativos fundamentados nos princípios da EPS contribuem para a transformação do processo de trabalho, ao favorecer a comunicação efetiva, a proatividade e o desenvolvimento de relações interpessoais mais empáticas no ambiente organizacional. Esses aspectos são essenciais para o exercício das competências gerenciais, uma vez que fortalecem o trabalho em equipe, o planejamento estratégico e a liderança colaborativa no contexto hospitalar.

Apesar de seu potencial transformador, a EPS ainda enfrenta dificuldades para ser incorporada de forma prioritária nas políticas institucionais, frequentemente em razão de limitações estruturais, financeiras e de uma compreensão restrita de sua abrangência. A superação dessas limitações requer que os gestores reconheçam a EPS como uma estratégia de transformação organizacional, capaz de promover mudanças sustentáveis, qualificar os processos de gestão e fortalecer a governança nos serviços hospitalares⁽¹⁹⁾.

A EPS não deve ser compreendida apenas como estratégia pedagógica, mas também como dispositivo organizacional que incide sobre os modos de governar o trabalho em saúde, ao definir quais problemas são priorizados, quais competências devem ser desenvolvidas e quais práticas são consideradas legítimas. A EPS participa da produção de racionalidades institucionais e da conformação de subjetividades profissionais. Nesse sentido, sua implementação pode tanto fortalecer autonomia e a corresponsabilização coletiva quanto operar como mecanismo de alinhamento às diretrizes gerenciais vigentes, evidenciando sua dimensão político-institucional.

CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

A escassez de profissionais qualificados em diversas instituições hospitalares evidencia desafios relacionados à organização do trabalho e à capacidade de resposta às demandas assistenciais. Nesse contexto, a EPS configura-se como uma estratégia fundamental, uma vez que, por meio de processos educativos contínuos, favorece o desenvolvimento de competências, amplia a segurança profissional e fortalece a capacidade das equipes para ofertar um cuidado qualificado e resolutivo⁽²¹⁾.

Os achados de Ferreira, Balsanelli e Santos⁽¹⁸⁾ reforçam a relação entre a qualificação profissional e o fortalecimento de estratégias educacionais permanentes. Segundo os autores, a ausência de programas estruturados de EPS impacta negativamente a percepção de competência dos profissionais, contribuindo para a insatisfação no trabalho, aumento do absenteísmo e fragilização da qualidade da assistência prestada. Assim, a EPS emerge como elemento mediador entre gestão de pessoas, organização do trabalho e qualidade do cuidado.

Treinamentos contínuos e sistematizados constituem-se como instrumentos essenciais para a qualificação da assistência em saúde, uma vez que fortalecem a confiança dos profissionais, promovem maior integração das equipes e favorecem práticas mais seguras e eficientes. Conforme evidenciado por Zagalioti *et al.*⁽²²⁾, intervenções educativas contribuem para a melhoria do desempenho profissional e para o aumento da segurança na execução das atividades, aspectos diretamente relacionados à qualidade dos serviços hospitalares.

Adicionalmente, diante de cenários organizacionais complexos, que extrapolam o cuidado direto ao paciente, torna-se evidente a necessidade de programas educativos voltados ao desenvolvimento de habilidades críticas, à tomada de decisão e ao enfrentamento de situações desafiadoras no ambiente hospitalar⁽²³⁾. Os estudos de Zhang *et al.*⁽²⁴⁾ e Lam *et al.*⁽²³⁾ demonstram que ações educativas estruturadas favorecem a ampliação da capacidade de resposta dos profissionais, impactando positivamente tanto a organização do cuidado quanto a comunicação institucional.

A incorporação de estratégias educativas inovadoras, como os programas de “*Death Education*”, evidencia que a EPS pode promover mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, ao estimular a reflexão crítica e a ressignificação das práticas profissionais. Esses avanços repercutem não apenas na dimensão assistencial, mas também nas dinâmicas organizacionais, contribuindo para uma gestão mais eficiente e para a oferta de um cuidado mais equitativo e centrado no paciente^(21, 24).

Observa-se, contudo, o risco de instrumentalização da EPS quando esta é reduzida a ferramenta operacional voltada exclusivamente ao alcance de metas institucionais ou à

padronização de protocolos. Nessa perspectiva, a EPS pode perder seu caráter problematizador e transformador, sendo apropriada como estratégia de ajuste do trabalhador às demandas organizacionais, em vez de constituir-se como espaço crítico de reflexão sobre o próprio processo de trabalho. Tal deslocamento compromete sua potência emancipatória e restringe seu alcance à dimensão técnica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados do presente estudo evidenciam que a EPS constitui uma estratégia relevante para o aprimoramento da gestão hospitalar, ao contribuir para a qualificação das condições de trabalho e para a superação de entraves técnicos e organizacionais. Nesse contexto, a EPS destaca-se como um elemento fundamental para o fortalecimento das competências gerenciais dos enfermeiros gestores, favorecendo o desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e construtivo, indispensável à condução dos processos de gestão nos serviços de saúde.

Os resultados também apontam para a necessidade de ampliação das pesquisas no campo da EPS, tanto no âmbito da gestão hospitalar quanto na interface com a qualidade da assistência. Observa-se que a consolidação dessa prática requer investimentos contínuos e o desenvolvimento de estratégias educacionais inovadoras, alinhadas às demandas reais dos gestores e das equipes multiprofissionais. Para que seus efeitos sejam efetivos, torna-se essencial que as ações de EPS sejam planejadas e executadas de forma integrada, articulando os fundamentos teóricos às vivências práticas do cotidiano de trabalho.

Adicionalmente, o uso de tecnologias educacionais desponta como um recurso estratégico para potencializar os processos de ensino-aprendizagem, ao possibilitar maior flexibilidade, acessibilidade e adequação às dinâmicas do ambiente hospitalar. Essas ferramentas contribuem para que o aprendizado deixe de assumir um caráter passivo, passando a configurar-se como um processo contínuo, colaborativo e dinâmico, capaz de fortalecer a formação profissional e impactar positivamente a organização do trabalho e a qualidade da assistência prestada.

O recorte temporal da presente revisão, que abrange o período pós-2020, coincide com os efeitos organizacionais da pandemia de covid-19, contexto que reconfigurou significativamente as estratégias educativas nos serviços hospitalares. A necessidade de respostas rápidas frente à emergência sanitária intensificou a adoção de treinamentos pontuais e modelos de ensino remoto, muitas vezes priorizando a atualização técnica imediata em

detrimento de processos reflexivos mais amplos. Esse cenário pode ter influenciado o predomínio de intervenções educativas de caráter instrumental identificadas na literatura recente, indicando a necessidade de investigações futuras que analisem a consolidação da EPS em contextos pós-pandêmicos.

Dessa forma, a EPS reafirma-se como uma estratégia essencial para a qualificação da gestão hospitalar e para a transformação das práticas em saúde, ao promover a integração entre educação, gestão e cuidado, em consonância com os princípios do sistema de saúde e com as necessidades contemporâneas dos serviços hospitalares.

Apesar da relevância dos achados, esta revisão apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. O número reduzido de estudos incluídos evidência a ainda limitada produção científica que articula explicitamente a EPS à gestão hospitalar sob a perspectiva da enfermagem. Essa restrição quantitativa pode impactar a abrangência das inferências realizadas, sobretudo no que se refere à generalização dos resultados para diferentes contextos institucionais. Ademais, a predominância de delineamentos qualitativos e quase-experimentais, com níveis de evidências moderadas ou baixos, reforça a necessidade de cautela na extrapolação dos efeitos organizacionais atribuídos às intervenções educativas. Assim, recomenda-se a ampliação de investigações com metodologias mais robustas, capazes de produzir evidências comparativas e análises de impacto em diferentes cenários hospitalares.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 198/GM, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
2. Ribeiro DK, Friedrich DB de C. Educação permanente em saúde e gestão do conhecimento: iniciativas na superintendência regional de saúde. *Cogitare Enferm* [Internet]. 2023;28:e92028.
3. Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal; 1988.
4. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: Presidência da República; 1990.
5. Silva PA, Lourenço MP, Baldissera VDA. Educação permanente em Saúde: *Design*

Thinking para planejamento e construção de diretrizes. Esc Anna Nery [Internet]. 2023;27:e20220397.

6. Iglesias A, Garcia DC, Pralon JA, Badaró-Moreira MI. Educação Permanente no Sistema Único de Saúde: Concepções de Profissionais da Gestão e dos Serviços. Psicol cienc prof [Internet]. 2023;43:e255126.

7. Nogueira ALG, Munari DB, Sousa ET, Ribeiro LCM. Planejamento de sucessão de lideranças em enfermagem: caminhos para sua elaboração. Rev esc enferm USP [Internet]. 2021;55:e03758.

8. Brasil. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde: Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. (Série Pactos pela Saúde; v. 9).

9. Bardella AC. O papel do enfermeiro na Gestão Hospitalar e suas competências. Sci. Electronic Arch. 2024;17(3):1-7.

10. Koerich C, Erdmann AL, Lanzoni GM de M. Professional interaction in management of the triad: Permanent Education in Health, patient safety and quality. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet]. 2020;28:e3379.

11. Fabricio de Souza J, Gomes de Fraga BL, de Castro Bezerra K, Gomes Santiago TS, Sales Ribeiro TF, de Queiroz Oliveira L, Rodrigues Pereira J, Uchoa Monteiro Rangel A. Gestão compartilhada: potencialidades do fortalecimento da integração ensino- serviço no âmbito hospitalar. Nursing Edição Brasileira [Internet]. 2023; 26(302):9793-6.

12. Sardinha Peixoto L, Cuzatis Gonçalves L, Dutra Da Costa T, Tavares CM de M, Dantas Cavalcanti AC, Antunes Cortez E. Educação permanente, continuada e em serviço: desvendando seus conceitos. Enferm. glob. [Internet]. 2013Jan;12(29):307-322.

13. Salas, E., Tannenbaum, S. I., Kraiger, K., & Smith-Jentsch, K. A. (2012). The science of training and development in organizations: What matters in practice. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(2), 74–101.

14. Peduzzi *et al.*, 2009

15. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein (Sao Paulo). 2010;8(1):102-6.

16. Mendes KDS, Silveira RC de CP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto contexto - enferm [Internet]. 2008Oct;17(4):758–64.

17. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2023. 627 p.

18. Ferreira KM, Balsanelli AP, Santos JLG dos. Competencia profesional de enfermeros en unidades de urgencias y emergencias: estudio de método mixto. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet]. 2023Jan;31:e3935.

19. Silva CIF, Ferreira IP, Trindade C dos S, Santos, VRC dos, Souza MLB de, Bezerra TC *et al.* Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: aspectos que compõem o perfil dos profissionais que atuam nas Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES) Regionais no Pará. *Res Soc Dev.* 2022;11(11):e78111133250.
20. Rodrigues Zinn G, Garcia Gomes Lecca C, Mira VL, Tavares dos Santos P, Silva EM. Educação permanente em saúde como prática possível: uma experiência na atenção primária. *Ciênc. cuid. saúde* [Internet]. 2022;210: e59584.
21. Wilson E, Varcoe C, Wathen N. Beyond Education: What is required to support staff to promote equity-oriented health care in EDs? *Ann Fam Med.* 2024Nov;21(Suppl 3):5420.
22. Zagalioti SC, Fyntanidou B, Exadaktylos A, Lallas K, Ziaka M. The first positive evidence that training improves triage decisions in Greece: evidence from emergency nurses at an Academic Tertiary Care Emergency Department. *BMC Emerg Med.* 2023May;23(1):60
23. Lam SKK, Kwong EWY, Hung MSY, Chien WT. Investigating the Strategies Adopted by Emergency Nurses to Address Uncertainty and Change in the Event of Emerging Infectious Diseases: A Grounded Theory Study. *Int J Environ Res Public Health.* 2020 Apr 6;17(7):2490.
24. Zhang H, Hu M, Zeng L, Ma M, Li L. Impact of death education courses on emergency nurses' perception of effective behavioral responses in dealing with sudden death in China: A quasi-experimental study. *Nurse Educ Today.* 2020 Feb;85:104264.

ARTIGO 2: AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA FRONTEIRA: OLHAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM HOSPITALAR

CONTINUING HEALTH EDUCATION ACTIONS AT THE BORDER: THE NURSING TEAM'S PERSPECTIVE IN A HOSPITAL

RESUMO

A Educação Permanente em Saúde (EPS) constitui estratégia essencial para qualificar o trabalho em saúde, especialmente em regiões de tríplice fronteira, onde a dinâmica assistencial é marcada por elevada demanda, diversidade cultural e circulação de usuários de diferentes nacionalidades. Diante desse cenário, torna-se necessário compreender como os profissionais vivenciam e percebem as ações educativas ofertadas pelas instituições. Assim, este estudo teve como objetivo analisar as percepções da equipe de enfermagem sobre as práticas de EPS desenvolvidas pelo Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão de um hospital público localizado em região fronteiriça. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada na Análise de Conteúdo, realizada com 20 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros e técnicos, entrevistados por meio de roteiro semiestruturado. A análise revelou desafios como falta de tempo para participação, apoio institucional limitado, metodologias pouco dinâmicas e dificuldades estruturais que comprometem o engajamento e a aplicação prática dos conteúdos. Apesar das limitações, os participantes reconhecem que a EPS contribui para a atualização profissional, segurança do paciente e fortalecimento das competências técnicas e relacionais. Conclui-se que a consolidação de uma cultura de aprendizagem contínua exige maior valorização institucional, estratégias pedagógicas mais flexíveis e conteúdos alinhados às especificidades da assistência em regiões de fronteira, reforçando os princípios de integralidade, equidade e universalidade do SUS.

Palavras-chave: Educação Permanente; Hospital; Pesquisa Qualitativa; Enfermagem.

ABSTRACT

Continuing Health Education (CHE) is an essential strategy for improving healthcare practices, particularly in tri-border regions where service dynamics are influenced by high demand, cultural diversity, and the constant circulation of users from different countries. In this context, understanding how nursing professionals perceive and experience educational activities becomes fundamental for strengthening care quality. This study aimed to analyze the perceptions of the nursing team regarding the CHE practices developed by the Education, Research, and Extension Center of a public hospital located in a tri-border area. This qualitative research was based on Content Analysis and conducted with 20 nursing professionals, including nurses and nursing technicians, interviewed through a semi-structured script. The analysis revealed challenges such as lack of time for participation, limited institutional support, undynamic methodologies, and structural barriers that hinder engagement and the practical application of training content. Despite these limitations, participants acknowledged that CHE contributes to professional development, patient safety, and the strengthening of technical and relational competencies. The study concludes that consolidating a culture of continuous learning requires greater institutional commitment, more

flexible pedagogical strategies, and content aligned with the specificities of healthcare delivery in border regions, reinforcing the principles of comprehensiveness, equity, and universality of the Brazilian Unified Health System (SUS).

Keywords: Continuing Education; Hospital; Qualitative Research; Nursing.

INTRODUÇÃO

A Educação Continuada e a Educação Permanente em Saúde (EPS) devem ser vistas como ferramentas fundamentais para a transformação das práticas de saúde. Para que essas iniciativas tenham impacto efetivo, é essencial que se desenvolva um planejamento descentralizado e coletivo, integrado aos instrumentos de gestão, de modo a refletir as especificidades dos diferentes contextos de trabalho. No entanto, essa implementação ainda enfrenta desafios, principalmente pela falta de conhecimento concreto sobre estratégias e métodos eficazes para o planejamento e execução da EPS (Higashijima *et al.*, 2023).

De acordo com Oliveira *et al.*, (2024), a EPS não só aprimora as capacidades técnicas dos enfermeiros, mas também fortalece suas habilidades administrativas e de liderança, essenciais para a coordenação eficaz das equipes e a melhoria da qualidade do atendimento. Essas capacitações permitem que os gestores hospitalares enfrentem desafios impostos, como a gestão de recursos humanos, a resolução de conflitos e a tomada de decisões estratégicas, resultando em um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente. Além disso, ajudam a alinhar as práticas de gestão às mudanças tecnológicas e às exigências regulatórias, promovendo uma gestão hospitalar adaptável e moderna.

Essa necessidade de adaptação torna-se ainda mais premente em cenários complexos, como a tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) altera significativamente as necessidades formativas da enfermagem. A elevada flutuação populacional gera demandas assistenciais instáveis, exigindo capacitação contínua em temas urgentes como comunicação intercultural, barreiras linguísticas e particularidades epidemiológicas transfronteiriças. Esse território demanda uma EPS distinta da convencional, requerendo respostas formativas sensíveis à diversidade cultural e à complexidade organizacional da região (Giovannella *et al.*, 2007; Gnoatto; Mondardo, 2024; Souza *et al.*, 2024).

Diante desse panorama de especificidades territoriais, a presente pesquisa propõe-se a analisar as percepções da equipe de enfermagem sobre as práticas de EPS e seus impactos na assistência em uma instituição hospitalar situada na região de tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. A partir disso, busca-se responder à seguinte questão norteadora: “qual

a percepção da equipe de enfermagem sobre os cursos de capacitação e treinamentos realizados e seus efeitos no cotidiano da assistência em um hospital público localizado na região de tríplice fronteira”?

Para sustentar essa análise, é preciso considerar que a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Brasil, 2009) institui a formação como estratégia indissociável do trabalho para qualificar o cuidado e fortalecer o SUS. Contudo, sua materialização enfrenta restrições orçamentárias e precarização laboral, gerando tensão entre o desenho normativo e a prática (Cardoso *et al.*, 2017; Ribeiro; Friedrich, 2023). No cotidiano, a integração das ações é dificultada pela sobrecarga e fragmentação das equipes, expondo a complexidade de conciliar cuidado e formação. Assim, a EPS transcende a dimensão pedagógica para revelar as contradições entre diretrizes institucionais e a realidade dos trabalhadores em cenários de alta pressão (Barcellos *et al.*, 2020; Ceccim; Feuerwerker, 2004; Merhy, 2004).

Essa distância entre o desenho normativo da EPS e sua efetivação concreta torna-se mais visível em contextos hospitalares de fronteira, marcados por sobrecarga assistencial, instabilidade territorial e demandas formativas específicas (Giovanella *et al.*, 2007; Nery, 2021). O cuidado nesse cenário exige sensibilidade aos determinantes sociais e culturais que influenciam a oferta e recepção dos serviços de saúde. Nesse contexto, a EPS adquire significado relevante ao fomentar um atendimento seguro e humanizado para usuários locais e itinerantes (Krüger *et al.*, 2017).

Assim, em áreas de fronteira, os profissionais de enfermagem enfrentam particularidades que demandam competências e saberes específicos, devido à presença de populações classificadas como flutuantes. Trata-se de indivíduos que atravessam diariamente a fronteira em busca de melhores condições de atendimento no sistema de saúde brasileiro. No entanto, como mantêm residência em seus países de origem e não têm intenção de se estabelecer permanentemente no Brasil, não são caracterizados como migrantes (Costa *et al.*, 2023).

O enfermeiro como gestor do cuidado, deve desenvolver competências para uma atenção humanizada na fronteira, alinhada à equidade e universalidade do SUS. Contudo, a implementação de políticas públicas enfrenta barreiras em todos os níveis de atenção. Um entrave central é a invisibilidade dessas populações nos registros orçamentários, o que compromete o planejamento financeiro e a eficácia das estratégias de saúde coletiva nessas regiões (Arenhart *et al.*, 2022).

Somando-se às limitações orçamentárias, a carência de políticas e acordos

internacionais, conforme apontam Furquim (2023) e França, Areosa e Figueiredo (2021), a carência de políticas e acordos internacionais dificulta a integração dos sistemas de saúde fronteiriços. Essa fragilidade compromete o planejamento da assistência e impõe desafios aos enfermeiros, que enfrentam lacunas na oferta do cuidado integral e humanizado. Dada à diversidade das comunidades de fronteira, torna-se imperativo adotar abordagens territoriais adaptadas às dinâmicas locais.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo, tendo como base a Análise de Conteúdo de Minayo (Minayo, 2014), voltado a conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre as atividades de EPS desenvolvidas pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) de um hospital de fronteira. Para orientar a condução da pesquisa, foram adotados os critérios do *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research* (COREQ) que orientaram a descrição do contexto, dos participantes, do papel da pesquisadora e das estratégias de rigor adotadas ao longo da coleta e da análise dos dados.

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2001), foca na compreensão das relações sociais e nos significados que os sujeitos atribuem às suas vivências, permeadas por valores e atitudes. Ao interpretar instituições como construções humanas, essa abordagem busca revelar os sentidos profundos dos fenômenos. Para tanto, a análise de conteúdo proposta pela autora estruturada em pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados organiza e codifica as mensagens, evidenciando sentidos explícitos e implícitos. Essa técnica alia rigor e sensibilidade para aprofundar a compreensão da realidade investigada.

A concretização desta proposta no campo empírico fundamentou-se na participação ativa da equipe de enfermagem de um hospital público de fronteira, cujas vivências são centrais para a compreensão da realidade. A coleta de dados foi realizada por uma pesquisadora integrante do quadro funcional da instituição, com formação em Pedagogia. Essa inserção prévia no cenário de estudo e a expertise pedagógica favoreceram a compreensão das dinâmicas educativas locais e o estabelecimento de um vínculo de confiança com os participantes. Para assegurar o rigor ético e mitigar possíveis vieses de assimetria ou desejabilidade social decorrentes da relação profissional preexistente, adotou-se o distanciamento reflexivo durante as entrevistas. Estas ocorreram em local reservado, com garantia estrita de anonimato e o reforço de que a participação era voluntária e sem qualquer vínculo com a avaliação de desempenho funcional. Como estratégia de fidedignidade, as

transcrições foram validadas pelos entrevistados (*member checking*), assegurando a autenticidade dos relatos.

Os critérios de inclusão estabelecem a participação de profissionais com vínculo efetivo na instituição hospitalar, que estejam em exercício há pelo menos seis meses e que já tenham participado das atividades promovidas pelo NEPE. Por outro lado, foram excluídos da pesquisa os profissionais que estivessem em período de férias ou afastamento durante a fase de coleta de dados.

Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado, desenvolvido pelos pesquisadores, contendo questões sobre a experiência dos profissionais com o programa de EPS institucional. O instrumento objetivou captar percepções, vivências e significados atribuídos às atividades, permitindo uma abordagem aprofundada. O roteiro foi dividido em 7 seções: Participação e frequência; Avaliação de temas e conteúdo; Qualidade; Impactos no desenvolvimento profissional; Satisfação e sugestões; Avaliação de estrutura; e Impactos em longo prazo.

Participaram do estudo 20 profissionais de enfermagem, sendo 10 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem atuantes em diferentes setores do hospital (Pronto-Atendimento Adulto Infantil, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Setores de Internação, Hemodinâmica e Ambulatório). A seleção buscou garantir diversidade de setores e turnos de modo a contemplar diferentes experiências com as ações de EPS ofertadas pelo NEPE.

A amostra foi do tipo intencional, selecionada por critérios de diversidade profissional, setores e experiência com a EPS. O quantitativo de participantes não buscou a saturação teórica, mas a compreensão aprofundada de diferentes perfis no contexto de tríplice fronteira, conforme a abordagem qualitativa interpretativa. A coleta ocorreu entre julho e novembro de 2025, com entrevistas de 15 a 30 minutos, gravadas e transcritas via aplicativo Riverside®. Como estratégia de rigor, os participantes receberam as transcrições por telefone para conferência; na ausência de manifestação em cinco dias, os relatos foram validados e incluídos na pesquisa.

A pré-análise envolveu a organização do corpus e a leitura flutuante para identificação de temas recorrentes sobre a EPS. Na exploração do material, leituras horizontais sistematizaram o conteúdo em categorias analíticas. No tratamento dos resultados, os dados foram interpretados em profundidade para atender aos objetivos do estudo. As categorias emergiram de forma indutiva das falas, com codificação inicial revista por um segundo

pesquisador para garantir a confiabilidade interpretativa. A análise foi conduzida manualmente, sem uso de softwares, o que permitiu maior proximidade e leituras reiteradas do material empírico, consolidando as categorias e subcategorias finais.

O estudo atendeu às exigências éticas, obtendo aprovação do Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (CAAE: 88991625.7.0000.0107) e da instituição hospitalar. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, garantindo voluntariedade e sigilo, sendo identificadas como: Enfermeiros (E1 a E10) e Técnicos de Enfermagem (T1 a T10).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes tinham entre 20 e 56 anos (média de 38 anos), com experiência profissional variando de 2 a 13 anos. No grupo dos enfermeiros, seis possuíam pós-graduação lato sensu e quatro eram graduados ou especializando. Quanto aos técnicos, cinco haviam concluído o ensino superior, quatro possuíam apenas o nível técnico e um estava em formação. A maioria dos profissionais atua em regime de plantão (12x36h), com cargas horárias entre 36 e 44 horas semanais. A análise das entrevistas resultou em categorias que expressam as percepções da equipe sobre a EPS.

A FORMAÇÃO EM DISPUTA: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE TENSIONADA PELA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ASSISTENCIAL.

Os participantes reconhecem a importância das ações de EPS, porém relatam dificuldades recorrentes para participar das atividades ofertadas. As falas indicam que a frequência é comprometida principalmente pela alta demanda assistencial, pela imprevisibilidade dos plantões e pela dificuldade de liberação das equipes durante o horário de trabalho. De modo geral, a baixa participação não é atribuída à falta de interesse profissional, mas às condições concretas do processo de trabalho hospitalar.

“A gente encontrava dificuldade principalmente porque era no horário de plantão” (E7).

“[...] várias vezes a gente deixa de ir porque tem paciente em intercorrência, essa é a nossa maior dificuldade [...]” (T10).

Nas entrevistas, observou-se que a equipe de enfermagem enfrenta diversos desafios

para programar as ações de educação permanente. Muitas vezes, o obstáculo está na ausência de suporte adequado, como recursos humanos insuficientes e equipes incompletas nos setores, o que dificulta a criação de um sistema de revezamento para participação nas atividades educativas. Essa limitação acaba gerando desmotivação para reaprender e adquirir novas técnicas de trabalho, além de dificultar o domínio de tecnologias essenciais para a qualidade do atendimento prestado aos pacientes e seus familiares.

O estudo evidencia que a dinâmica assistencial da tríplice fronteira, marcada por demandas flutuantes de turistas e migrantes, gera uma sobrecarga que impede a liberação da equipe para capacitações. A participação torna-se refém da pressão do serviço, e não do interesse profissional. Embora a EPS se fortaleça com garantias estruturais de participação (Lamante *et al.*, 2019), a imprevisibilidade dos fluxos assistenciais locais limita essa condição. Essa tensão reflete-se negativamente nos indicadores do NEPE e nos índices de avaliação institucional. Conclui-se que a baixa adesão não é desinteresse, mas resultado do conflito entre a assistência contínua e a necessidade de momentos formativos, essenciais para a reflexão e reorganização das práticas em saúde.

Os participantes relataram barreiras críticas para a efetivação da EPS, destacando uma desmotivação generalizada que atinge desde a enfermagem até as instâncias de gestão setorial e geral. Os relatos evidenciam que a fragilidade do apoio institucional compromete o engajamento das equipes. Diante desse cenário, há um apelo por maior colaboração gestora para que as atividades educacionais adquiram sentido prático, permitindo que o conhecimento seja efetivamente disseminado e incorporado à rotina assistencial como uma ferramenta de atualização real.

Conforme Macêdo *et al.*, (2019), a falta de priorização das ações educativas reforça a necessidade de práticas alinhadas aos princípios da EPS. Em hospitais de tríplice fronteira, essa dificuldade é intensificada pela circulação internacional de usuários e pela imprevisibilidade da demanda assistencial. Nesse cenário, a EPS exige estratégias diferenciadas que reconheçam a complexidade territorial e integrem a formação ao fluxo real de trabalho, mitigando a exclusão formativa dos profissionais diante da alta rotatividade e sobrecarga do serviço.

“Sinceramente é algo que considero importante, mas não vejo apoio real da instituição. A gerência não facilita a liberação da equipe, e muitas vezes somos sobrecarregadas, o que torna inviável a participação” (E6).

“Eu preferiria vir da minha casa pra participar do que sair do plantão, porque às vezes você acabava deixando uma criança desassistida” (E7).

“Várias vezes a gente deixa de ir porque tem paciente em intercorrência, tem procedimento agendado” (T10).

Diante dos desafios presentes no trabalho hospitalar, torna-se evidente a necessidade de ações educativas, uma vez que a formação inicial não é suficiente para responder à complexidade da prática. Nesse cenário, a educação continuada baseada em saberem científico e articulado ao trabalho em equipe com caráter reflexivo mostra-se fundamental para ressignificar práticas e qualificar o cuidado, especialmente no âmbito da EPS (Peduzzi *et al.*, 2020).

ENTRE CONTEÚDO E MÉTODO: QUALIDADE E IMPACTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Os profissionais reconhecem a relevância da EPS para a segurança do paciente e atualização técnica, evitando a cronificação de práticas inadequadas. Contudo, relatam desvalorização e um distanciamento entre os temas ofertados e as demandas reais da instituição. Evidencia-se uma lacuna crítica: a desconsideração das singularidades da fronteira e da diversidade de nacionalidades no atendimento. Essa desconexão entre o conteúdo e o contexto territorial compromete a resolutividade das ações, gerando a percepção de que as formações não atendem plenamente aos desafios cotidianos da assistência hospitalar.

“Os temas abordados são, em geral, pouco aplicáveis à realidade da ortopedia. O treinamento nunca é específico de um setor, sempre são para todos” (E6).

“Sinto falta de conteúdos mais técnicos voltados para nossa realidade” (T6).

Contudo, houve participantes que referem estar satisfeitos com a realidade vivenciada e as atividades do NEPE que participa, referindo que se sentem valorizados e que há uma interlocução com as necessidades do trabalho.

“Capacita e prepara o profissional para desempenhar seu trabalho com exatidão” (E3).

“[...] são pensados de acordo com as necessidades observadas no hospital” (E4).

As críticas recorrentes apontam para a repetição de conteúdos e a predominância de abordagens teóricas pouco didáticas, com limitada adequação às especificidades dos diferentes setores (Ortopedia, Ambulatório, Cuidados Paliativos). Profissionais experientes

percebem os treinamentos mais como “revisões” superficiais do que aprofundamentos, refletindo a ausência de escuta das necessidades reais da assistência. Consequentemente, o impacto formativo é heterogêneo, condicionado à aplicabilidade prática e à contextualização setorial. Essa desconexão influencia diretamente a percepção de valorização profissional e o sentido atribuído às ações de EPS no cotidiano institucional.

Conforme Higashijima *et al.*, (2023), as ações educativas integradas ao cotidiano assistencial não devem ser entendidas como atividades pontuais e desvinculadas do trabalho, mas incorporadas ao próprio processo laboral, com o objetivo de qualificar a assistência. Essa integração favorece mudanças na prática profissional, alinhando a formação às necessidades reais dos serviços e dos usuários. Ao articular processos educativos e desenvolvimento profissional, torna-se possível promover transformações nas práticas de cuidado e na organização do trabalho, em consonância com os princípios da Política Nacional de EPS (Brasil, 2009).

Desse modo, percebe-se que a eficácia da EPS depende do domínio técnico dos facilitadores; a carência desse preparo compromete a credibilidade do processo formativo. A repetitividade temática torna as ações monótonas, gerando desinteresse e a presunção de redundância pelos colaboradores. Portanto, para evitar o distanciamento da equipe, é essencial que os articuladores demonstrem domínio sobre o conteúdo, garantindo que as qualificações transcendam a repetição e promovam uma transmissão de conhecimento efetiva e engajadora.

Essa necessidade de engajamento esbarra, entretanto, na forma de entrega ainda que reconheça a relevância dos temas, os participantes criticam o uso de metodologias meramente expositivas e teóricas, com baixa interatividade. Diante da demanda intensa da tríplice fronteira, onde situações críticas são frequentes, sugere-se a adoção de metodologias ativas e simulações práticas. Tais abordagens aproximariam o ensino da realidade assistencial, favorecendo o engajamento e a apropriação do conteúdo. Dessa forma fica evidente que a percepção de baixa eficácia não decorre da falta de temas, mas da inadequação metodológica ao ritmo e às necessidades concretas do serviço hospitalar.

“Achei pouco didática e muita leitura de slide, que se torna cansativo e repetitivo” (E3).

“Muitas vezes são apenas palestras com muitos slides, sem espaço para interação” (T6).

“Gosto muito de estudos de caso e simulações, mas é raro esse tipo de treinamento” (T5).

“Eu acho mais importante quando eles vêm aqui presencialmente do que passar no

computador” (T4).

Alguns participantes relataram efeitos positivos das capacitações na prática assistencial, destacando melhorias na segurança do paciente, na tomada de decisão e na qualidade do cuidado prestado. No entanto, alguns profissionais não identificaram mudanças significativas, o que pode estar relacionado à ausência de indicadores objetivos que permitam mensurar os resultados dessas ações formativas.

“[...] incluir mais atividades práticas, simulações e estudos de caso torna mais realista da nossa realidade” (T6).

“A pessoa que esteja responsável pelo treinamento tenha conhecimento prático e teórico” (E5).

“[...] poderia haver maior aprofundamento técnico e prático para atender as profissionais...” (T1).

“[...] simulações é uma forma mais dinâmica de aprender” (E8).

“[...] poderia haver mais atividades práticas e interativas, seriam interessantes para o grupo vivenciar na prática o treinamento” (T5).

“[...] podia melhorar um pouco mais a parte de didática, de achar alguma outra metodologia” (T10).

É fundamental que as práticas de EPS se baseiem nos problemas identificados pela equipe, promovendo uma aprendizagem orientada para a resolução dessas questões. Nesse processo, os trabalhadores devem assumir um papel ativo, especialmente diante das transformações tecnológicas, que além de gerar novas demandas, ampliam as possibilidades de circulação do conhecimento e da experiência, tornando-se recursos essenciais para o desenvolvimento profissional (Germano *et al.*, 2022).

A valorização de simulações práticas reflete a busca por estratégias que mimetizem o cotidiano hospitalar, superando abordagens meramente expositivas. A simulação integra conhecimento técnico, tomada de decisão e trabalho em equipe, favorecendo a reflexão e respostas seguras em cuidados complexos. Conforme Cant e Cooper (2010) e Cook *et al.*, (2011), essa metodologia desenvolve competências clínicas, comunicação e raciocínio crítico em ambiente protegido. Assim, a preferência dos participantes por esse formato sinaliza a necessidade de métodos que dialoguem com a complexidade do trabalho, consolidando a EPS como espaço de problematização e qualificação assistencial.

A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA PRÁTICA: PERCEPÇÕES,

APLICABILIDADE E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Os impactos da EPS no cotidiano laboral são percebidos de forma ambivalente. Positivamente, os treinamentos elevam a segurança profissional, a confiança técnica e o alinhamento a novos protocolos, especialmente em procedimentos de risco.

“Depois do treinamento, a gente se sente mais segura para fazer, principalmente quando muda alguma coisa no protocolo” (E7).

“Ajuda a lembrar e a ter mais certeza do que está fazendo, principalmente em situações mais críticas” (T1).

“Treinamento ajuda para estar evitando a contaminação cruzada, diminuindo o risco de adoecimento” (E8).

Contudo, essa eficácia é frequentemente pontual e efêmera, limitada pelas condições objetivas de trabalho e pela dificuldade de transposição do aprendizado para a prática assistencial. Embora as capacitações reforcem cuidados essenciais e promovam tranquilidade no desempenho das funções, sua sustentabilidade é desafiada pela desconexão entre o conteúdo e as demandas reais do serviço.

Em sentido semelhante, alguns profissionais destacaram que as ações formativas auxiliam na organização do trabalho e na tomada de decisão:

“A educação em saúde, eu acho que é fundamental para a gente mitigar erros e otimizar e dar uma boa assistência” (E7).

“Quanto mais preparado o profissional estiver, melhor ele vai realizar a assistência” (E5).

“Na assistência percebo que consigo desenvolver melhor minha prática com os treinamentos, preparam para as novas atualizações [...]” (E10).

No entanto, esse efeito positivo é relativizado pela percepção de que a sobrecarga assistencial, a rotatividade de profissionais e a ausência de tempo protegido dificultam a consolidação dos aprendizados no cotidiano.

“A gente até aprende, mas na prática, com a correria do plantão, acaba fazendo do jeito que dá” (T10).

A descontinuidade e a falta de acompanhamento pós-treinamento limitam a tradução do aprendizado em mudanças práticas, mantendo o impacto da EPS no plano subjetivo. Essa

tensão revela que a relevância teórica esbarra em limites institucionais e na alta complexidade hospitalar. Contudo, quando efetivada, a EPS permite que os profissionais atuem com maior segurança na tomada de decisão e desenvolvam liderança estratégica. Conforme apontam Ceccim e Feuerwerker (2004) e a OMS (2009), o refinamento de habilidades técnicas, como a administração segura de medicamentos e a comunicação empática, é o que consolida a qualificação da assistência (Peduzzi *et al.*, 2011; Street Junior *et al.*, 2009)

A prática da enfermagem é diretamente impactada pela formação contínua dos profissionais. Evidências apontam que aqueles que participam de programas de EPS apresentam desempenho superior na assistência clínica. A capacitação constante contribui para uma atenção à saúde mais qualificada e eleva os níveis de satisfação dos pacientes. A relação estreita entre formação profissional e qualidade do cuidado reforça a importância de investimentos estruturados em ações de EPS (Celeste; Maia; Andrade, 2021).

Essa necessidade de estruturação torna-se mais complexa no contexto de um hospital de fronteira, onde a satisfação dos profissionais é parcial, condicionada à necessidade de maior apoio institucional e planejamento logístico. No hospital de fronteira, a intensa demanda decorrente do fluxo migratório de pacientes (Brasil, Paraguai e Argentina) exige que as capacitações evitem horários de pico, que hoje comprometem a adesão. Embora necessária, a implementação de uma abordagem dialógica enfrenta barreiras práticas de flexibilidade e escala. Assim, o suporte da gestão surge como elemento central para compatibilizar o movimento assistencial internacional com a viabilidade das ações de EPS.

“São adequados, mas flexibilizar e oferecer alternativas em turnos diferentes facilitaria” (T1).

“Teria que ser uma abordagem conjunta, porque às vezes nem todos vão...” (T3).

“Acredito que o melhor horário seria durante o plantão” (T9).

“Os horários melhores para cada setor e a maneira de abordar o assunto” (T10).

O formato atual da EPS carece de viabilidade prática, exigindo ajustes estruturais e um planejamento participativo. A flexibilização organizacional de horários é determinante para a adesão, visto que a alta demanda leva os profissionais a priorizarem a assistência direta. É imprescindível que a gestão concilie o desenvolvimento profissional com a manutenção do cuidado, superando obstáculos como a escassez de recursos e a resistência institucional. Essa articulação é o que permite, conforme defendem Sousa *et al.* (2025), consolidar a EPS como uma prática cotidiana capaz de promover a aprendizagem contínua e a transformação cultural

necessária ao cenário atual da saúde.

Higashijima *et al.*, (2023) destacam que a EPS é um espaço privilegiado de diálogo entre trabalhadores e gestores, rompendo com a formação tradicional ao reconhecer o cotidiano como locus dinâmico de aprendizagem. Nesse sentido, as sugestões por setorialização e adequação de horários transcendem a logística; elas reivindicam que a organização do trabalho seja o elemento central da formação. Ao proporem ações próximas à realidade dos setores e compatíveis com os plantões, os profissionais evidenciam que a satisfação com a EPS reside na integração real entre formação e cuidado, e não apenas na oferta quantitativa de treinamentos.

GESTÃO, ESTRUTURA E CULTURA ORGANIZACIONAL: OS BASTIDORES DA EFETIVAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE

A aplicabilidade da EPS é condicionada pela estrutura física e pela organização do trabalho, demonstrando que o ensino não opera de forma isolada das condições concretas. A precariedade dos espaços e a falta de ambientes adaptados comprometem a experiência formativa e a percepção de valorização profissional. Além disso, a efetividade técnica é limitada pela escassez de insumos: a atualização de protocolos torna-se inócua quando a realidade institucional não provê os materiais necessários para sua execução. Assim, a articulação entre o NEPE, a infraestrutura e a logística de suprimentos é essencial para que o conhecimento se traduza em prática assistencial.

“Um espaço satisfatório com materiais e equipamentos disponíveis” (E3).

“Seria interessante ampliar as oportunidades e oferecer incentivos [...]” (T1).

“Já foi uma capacitação de curativo que ensinou qual a placa usar [...] quando você vai ver na prática não tem. A gente fica de mãos atadas porque não tem o material” (T9).

Conforme Cassiani e Dias (2022), a EPS enfrenta o equívoco de ser restrita à atenção primária, o que limita sua adoção no ambiente hospitalar e compromete a segurança do cuidado. Metodologias inadequadas e pouco fundamentadas reduzem a aplicabilidade das ações, distanciando a enfermagem da educação permanente. Somado a isso, Izaguirres *et al.*, (2022) destacam que a ausência de padronização no dimensionamento da equipe gera vulnerabilidade institucional: o subdimensionamento acarreta sobrecarga, erros e fragmentação do cuidado, enquanto o superdimensionamento desperdiça recursos. Portanto, o

dimensionamento adequado e metodologias consistentes são estratégias fundamentais para mitigar demandas gerenciais e promover a qualidade assistencial.

Em consonância com essa perspectiva, Sousa *et al.*, (2020) destacam que a EPS constitui um dispositivo capaz de promover a desconstrução de práticas alicerçadas em modelos instituídos de cuidado centrado no trabalho individualizado, fragmentado e mecanizado. Todavia, as percepções dos profissionais revelam que, apesar do potencial transformador da EPS, persistem desafios estruturais e metodológicos que limitam sua efetividade. Essas evidências reforçam que a atualização contínua não depende apenas da oferta de conteúdos, mas da criação de condições estruturais e metodológicas que favoreçam a aprendizagem significativa.

A realização de ações de EPS no próprio setor de trabalho, embora facilite o acesso, pode gerar desconforto devido à sobreposição com as demandas do cuidado. Interrupções constantes e a falta de distanciamento das responsabilidades assistenciais fazem com que a EPS seja percebida como uma sobrecarga, em vez de um espaço de reflexão. Nesse sentido, autores como Merhy (2002) e Ceccim e Feuerwerker (2004) ressaltam que a eficácia do processo depende de condições institucionais que garantam legitimidade e tempo protegido, sob o risco de a proximidade com o trabalho real comprometer a escuta e o aprendizado (Pinheiro; Azambuja; Bonamigo, 2018).

Para além das questões do espaço físico, emerge também a problemática do suporte organizacional manifesta pela carência de incentivos que resultam em frustração e desvalorização profissional.

“Falaram que a instituição ia pagar [...] nunca foi pago” (E7).

“Deveria ser uma ferramenta de valorização, mas não é tratada com seriedade” (E6).

Os impactos percebidos em longo prazo são positivos, mas pouco consolidado devido à falta de continuidade, alta demanda assistencial e variação constante do perfil dos usuários. A percepção de que a rotina impede a consolidação de práticas aprendidas evidencia a tensão entre a dinâmica acelerada da assistência e o tempo necessário para a maturação de competência em hospitais de Fronteira. A diversidade cultural linguística e epidemiológica dos usuários exige adaptação permanente, dificultando a estabilização de protocolos e rotinas.

“[...] percebo um clima mais colaborativo e voltado para o desenvolvimento profissional contínuo” (T1).

“Sim, essa cultura vem sendo desenvolvida há tempos” (E3).

“Acredito que sim, a cultura de aprendizado no hospital tem tido uma evolução” (E5).

“O ambiente não favorece o aprendizado. A cultura institucional ainda é muito engessada e pouco aberta à educação permanente” (E6).

Apesar de avanços pontuais na cultura de aprendizagem, a evolução é percebida como insuficiente. Persistem barreiras estruturais, como a escassez de materiais e a gestão centralizada, que desconsidera a realidade assistencial. A aplicabilidade do conhecimento é limitada pela falta de recursos e de acompanhamento pós-treinamento, evidenciando que a cultura organizacional ainda não valoriza plenamente a educação permanente. Embora existam esforços colaborativos, eles permanecem restritos, revelando um distanciamento entre as iniciativas educativas e a consolidação de um aprendizado contínuo e sustentado na instituição.

A política pública estabelece a educação permanente como prioridade no âmbito da saúde, exigindo um planejamento sistematizado que considere as especificidades culturais e institucionais de cada contexto (Dias; Martinez, 2024; Pavinati *et al.*, 2022). Para que essa diretriz se concretize, a qualificação deve fundamentar-se na problematização do cotidiano e nas necessidades identificadas pelos próprios trabalhadores. Entretanto, a distância entre o que é preconizado pela política e a execução real nos ambientes de trabalho permanecem como um desafio estrutural, evidenciando que a ressignificação das práticas depende de mais do que apenas diretrizes teóricas.

Diante desses obstáculos, torna-se relevante analisar as estratégias e instrumentos que podem potencializar a efetividade da EPS, bem como os impactos esperados na melhoria da qualidade da atenção à saúde, o que corrobora a visão da equipe de enfermagem nos relatos que denotam o anseio por melhorias e uma implantação mais fidedigna. Tal perspectiva busca garantir que não apenas a equipe de enfermagem, mas também toda a equipe hospitalar, incluindo profissionais multiprofissionais e administrativos, tenha acesso a uma educação permanente.

Diante desse cenário de dificuldades e iniciativas pontuais, torna-se fundamental entender que a EPS se contrapõe ao modelo tradicional de capacitações verticais, caracterizado pela oferta de cursos e treinamentos com conteúdo previamente definidos pelos gestores, muitas vezes desconectados das reais necessidades do processo de trabalho. Tal formato hierarquizado de ensino mostra-se insuficiente para orientar as diretrizes da PNEPS, conforme salientam Calheiros *et al.*, (2022).

Além disso, a EPS possui uma dimensão ética e política que exige repensar e reorganizar continuamente o processo de trabalho, com vistas à defesa dos direitos sociais e à consolidação de uma política pública estruturada. O modelo tradicional, por sua vez, apresenta-se rígido, pouco flexível e desconsidera as dimensões subjetivas e contextuais da prática profissional, dificultando o desenvolvimento integral dos trabalhadores da saúde (Bueno *et al.*, 2021).

A adoção de feedbacks estruturados e a valorização do engajamento vinculando a participação em treinamentos e comissões a critérios de promoção interna surgem como estratégias para fortalecer o ciclo de aprendizagem. Paralelamente, críticas à carência de cursos para áreas específicas, incluindo o setor administrativo, reforçam a necessidade de maior acompanhamento pelas lideranças. Para consolidar uma cultura de aprendizado contínuo e práticas seguras, é fundamental que a gestão invista em estratégias inclusivas e flexíveis, alinhadas às demandas reais e ao reconhecimento do comprometimento profissional.

CONCLUSÃO

Os achados confirmam que a EPS é reconhecida como essencial para a segurança e atualização da equipe de enfermagem, mas enfrenta tensões entre a norma e a prática. Em hospitais de tríplice fronteira, a complexidade assistencial e o fluxo migratório de usuários intensificam essas contradições, revelando que a eficácia da EPS depende de condições estruturais e não apenas pedagógicas. Conclui-se que ações homogêneas e expositivas possuem impacto restrito, sendo imperativo adotar metodologias participativas e garantir “tempo protegido” para a formação.

O estudo apresenta como limitações o cenário único e a amostragem intencional, que impedem a generalização, além do possível viés de proximidade da pesquisadora com o campo. Recomenda-se que pesquisas futuras utilizem a triangulação de métodos e incluam gestores e outras categorias profissionais. Para a gestão, fica o desafio em integrar formação e cuidado, transformando a EPS em uma estratégia de transformação real do trabalho e não apenas em uma revisão burocrática de conteúdo.

REFERÊNCIAS

ARENHART, C. G. M. *et al.* Concepções de formadores de opinião sobre cidadania e direito à saúde na fronteira trinacional. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e320406, 2022.

BARCELLOS, R. M. S. *et al.* Educação permanente em saúde: práticas desenvolvidas nos municípios do estado de Goiás. **Trabalho, Educação e Saúde**, 2020.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/educacao-e-pesquisa/qualificacao-profissional-em-vigilancia-sanitaria/politica-nacional-de-educacao-permanente-em-saude.pdf/view>. Acesso em: 18 out. 2025.

BUENO, J. V. C. *et al.* Educação Permanente em Saúde em Prevenção e Controle das Infecções em Unidade de Emergência. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 36, p. e-021175, 2021.

CALHEIROS, M. N. T. R. *et al.* A educação permanente no âmbito da saúde mental e o médico atuante na atenção primária. **Revista APS**, v. 25, supl. 1, p. 29–40, 2022.

CANT, R. P.; COOPER, S. J. Simulation-based learning in nurse education: systematic review. **Journal of Advanced Nursing**, v. 66, n. 1, p. 3–15, 2010. D

CARDOSO, M. L. M. *et al.* The National Permanent Health Education Policy in Public Health Schools: reflections from practice. *Ciências & Saúde Coletiva*, v. 22, n.5, p. 1489-1500, 2017.

CASSIANI, S. H.; DIAS, B. M. Perspectives for advanced practice nursing in Brazil. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 56, spe, p. e20210406, 2022.

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 14, n. 1, p. 41–65, 2004.

CELESTE, L. E. N.; MAIA, M. R.; ANDRADE, V. A. Capacitação dos profissionais de enfermagem frente às situações de urgência e emergência na atenção primária à saúde: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e443101220521, 2021.

COOK, D. A. *et al.* Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis. **JAMA**, Chicago, v. 306, n. 9, p. 978–988, 2011.

COSTA, P. P. S. *et al.* Direitos humanos e acesso à saúde em regiões de fronteira. **Revista Foco**, v. 16, n. 9, p. e3199, 2023.

DIAS, N. T. C.; MARTINEZ, M. R. Educação permanente em saúde no Brasil: contexto histórico aos dias atuais. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 6, p. e6867, 2024.

FRANÇA, J. R.; AREOSA, J.; FIGUEIREDO, V. C. N. Desafios do trabalho de enfermeiras na fronteira Brasil-Bolívia. **Revista Laborativa**, v. 10, n. 1, p. 68–91, 2021.

FURQUIM, G. G. T. Migrações internacionais no Brasil e a pandemia da Covid-19: esboço de suas consequências. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 23, n. 240, p. 72–84, 2023.

GERMANO, J. M. *et al.* Entre nós: educação permanente em saúde como parte do processo

de trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 1, p. e320110, 2022.

GIOVANELLA, L. *et al.* Saúde nas fronteiras: acesso e demandas de estrangeiros e brasileiros não residentes ao SUS nas cidades de fronteira com países do MERCOSUL na perspectiva dos secretários municipais de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, p. S251–S266, 2007.

GNOATTO, V.; MONDARDO, M. L. A fronteira como recurso social: migração de retorno de brasileiros do Paraguai em busca da saúde pública. **Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD**, [S. l.], v. 13, n. 25, p. 143–166, 2024. DOI: 10.30612/rmufgd.v13i25.17141.

HIGASHIJIMA, M. N. S. *et al.* Princípios e características da Educação Permanente em Saúde: resgate e resistência em favor de um SUS potente e em defesa da vida. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, supl. 1, 2023.

IZAGUIRRES, A. L. *et al.* Formação profissional da enfermagem para aprimoramento de competências: revisão integrativa. **Revista Recien – Revista Científica de Enfermagem**, v. 12, n. 38, p. 183–193, 2022.

KRÜGER, C. *et al.* Analysis of public policies for developing the Brazilian border strip. **Ambiente & Sociedade**, v. 20, n. 4, p. 39–60, 2017.

LAMANTE, M. P. S.; *et al.* A educação permanente e as práticas em saúde: concepções de uma equipe multiprofissional. **Revista Pesquisa Qualitativa**, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 230–244, 2019.

MACÊDO, W. T. P. *et al.* Adesão dos profissionais de enfermagem às práticas educacionais. **Revista Online de Pesquisa Cuidado é Fundamental**, v. 11, n. 4, p. 1058–1064, 2019.

MERHY, E. E. **Saúde**: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002. 192p.

MINAYO, M. C. de S. (Org.). **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 416p.

MINAYO, M. C. S. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, M. C. S. (org.). **Pesquisa Social**: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 9–29.

NERY, R. F. Problemáticas de saúde pública em região de tríplice fronteira: uma revisão integrativa. **Revista Varia Scientia – Ciências da Saúde**, v. 7, n. 1, p. 48–62, 2021.

OLIVEIRA, N. M. *et al.* Educação permanente ou continuada? Concepções de enfermeiros no cotidiano da atenção primária. **Enfermagem em Foco**, v. 15, p. e-202487, 2024.

PAVINATI, G. *et al.* Tecnologias educacionais para o desenvolvimento de educação na saúde: uma revisão integrativa. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, 2022.

PEDUZZI, M. *et al.* Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos

no trabalho interprofissional. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 18, supl. 1, p. e0024678, 2020.

PINHEIRO, G. E. W.; AZAMBUJA, M. S. DE .; BONAMIGO, A. W. Facilidades e dificuldades vivenciadas na Educação Permanente em Saúde, na Estratégia Saúde da Família. **Saúde em Debate**, v. 42, n. spe4, p. 187–197, 2018.

RIBEIRO, D. K.; FRIEDRICH, D. B. C. Educação permanente em saúde e gestão do conhecimento: iniciativas na superintendência regional de saúde. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, p. e92028, 2023.

SOUSA, D. D. DE. *et al.* O reflexo da educação permanente em saúde na prática de enfermagem. **Revista Sociedade Científica**, vol. 8, n. 1, p. 996-1014, 2025.

SOUSA, F. M. S. *et al.* Educação interprofissional e educação permanente em saúde como estratégia para a construção de cuidado integral na Rede de Atenção Psicossocial. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 30, n. 1, p. e300111, 2020.

SOUZA, E. N. DA C. DE. *et al.* Competency mapping of primary healthcare nurses on the Brazil-Paraguay border. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 45, p. e20230098, 2024.

STREET JUNIOR, R. *et al.* How does communication heal? Pathways linking clinician–patient communication to health outcomes. **Patient Education and Counseling**, Amsterdam, v. 74, n. 3, p. 295–301, 2009.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **WHO patient safety curriculum guide: multi-professional edition**. Geneva: WHO, 2009. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44091> Acesso em: 18 nov. 2025.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa evidenciam que a EPS ainda não é plenamente compreendida em sua concepção ampliada no contexto hospitalar, sendo frequentemente reduzida à lógica de atualização pontual e tecnicista. Essa compreensão restrita limita o potencial transformador da estratégia, que deveria fundamentar-se na problematização do processo de trabalho e na aprendizagem significativa produzida no cotidiano assistencial.

Nesse sentido, torna-se imperativo fortalecer uma visão abrangente da EPS, reconhecendo-a como uma estratégia estruturante para a qualificação das práticas e para o desenvolvimento crítico das equipes de enfermagem.

Essa mudança de paradigma, contudo, esbarra em condicionantes práticos do cenário investigado. No hospital de fronteira, a EPS configura-se como um recurso vital para a segurança do cuidado, mas sua efetividade permanece refém de fatores institucionais. Aspectos como a adequação das metodologias, a infraestrutura disponível e, sobretudo, o apoio da gestão emergem como elementos centrais.

Apesar de tais limitações, observa-se um engajamento resiliente de parte dos profissionais, o que sinaliza um potencial latente para a consolidação de práticas educativas mais participativas, desde que haja garantia de condições reais para a participação.

Todavia, os desafios para essa operacionalização revelam-se complexos e interdependentes. A resistência a mudanças e a dificuldade de sensibilização somam-se a entraves estruturais crônicos, como o dimensionamento insuficiente das equipes e a elevada rotatividade – fatores que comprometem a continuidade pedagógica.

Diante dessa realidade, os achados indicam que o setor responsável pela EPS, o NEPE, necessita revisar suas práticas, superando modelos centrados na transmissão passiva de informações. É fundamental que o setor atue de forma articulada à gestão, adotando metodologias sensíveis às demandas reais do trabalho e às especificidades culturais do território transfronteiriço.

Em última análise, a pesquisa permitiu desvelar as dinâmicas que atravessam a implementação da EPS em um hospital público de região de fronteira. Os resultados reforçam que, embora reconhecida como potência para a transformação, a efetivação da EPS exige investimento contínuo e compromisso político.

Conclui-se que o fortalecimento do SUS nesta região depende da capacidade institucional de retirar a educação da periferia das decisões e colocá-la como o eixo central da

valorização profissional e da segurança assistencial.

As evidências aqui apresentadas sustentam que a qualificação deve ser orientada pelas necessidades identificadas pelos próprios trabalhadores em suas atividades laborais (Dias; Martinez, 2024; Pavinati *et al.*, 2022), consolidando a EPS não como uma atividade acessória, mas como um elemento orgânico e transformador da cultura hospitalar (Sousa *et al.*, 2025).

REFERÊNCIAS

- AIKES, S.; RIZZOTTO, M. L. F. Integração regional em cidades gêmeas do Paraná, Brasil, no âmbito da saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 8, p. e00182117, 2018.
- ALMEIDA, L. P. de (Org.). **Saúde na Fronteira Brasil-Paraguai: territorialidades e intersectorialidades nas estratégias de cuidado e educação em saúde**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2024.
- ALMEIDA, T. M. C.; SANTOS, R. M. M.; SAMPAIO, D. M. N.; VILELA, A. B. A. Educação permanente como apoio ao PMAQ-AB. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 13, 2019.
- ALZAHIRANI, N.; JONES, R.; ABDEL-LATIF, M. E. Attitudes of doctors and nurses toward patient safety within emergency departments of two Saudi Arabian hospitals. **BMC Health Serv Res**. 2018 Sep 25;18(1):736. doi: 10.1186/s12913-018-3542-7. PMID: 30253774; PMCID: PMC6156948.
- ARAÚJO, K. J. F. **Gestão do conhecimento e comunidades de prática no serviço público: uma análise do Departamento de Assessoria Jurídica do Ministério Público da Paraíba**. 2019. Dissertação (Mestrado em Gestão nas Organizações Aprendentes). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019.
- ARENHART, C. G. M. *et al.* Concepções de formadores de opinião sobre cidadania e direito à saúde na fronteira trinacional. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e320406, 2022.
- BARCELLOS, R. M. S. *et al.* Educação permanente em saúde: práticas desenvolvidas nos municípios do estado de Goiás. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 18, n. 2, 2020.
- BERRES, R.; BAGGIO, M. A. (Dis)continuation of care of the pre-term newborn at the border. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 3, p. e20180827, 2020.
- BEZERRA, T. V.; DIAS, I. K. R. Satisfação da Enfermagem da Atenção Primária à Saúde com a Educação Permanente. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 46, n. 2, p. 104-121, 2022.
- BITENCOURT, G. R. *et al.* Uso de indicadores na avaliação do serviço de educação permanente: reflexão dos pilares da qualidade. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 35, 2021.
- BOSSAN, J. P. S. *et al.* Indicadores qualitativos de educação permanente em saúde: criação colegiada em uma regional de saúde. **Saúde E Pesquisa**. 2024.
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 330, de 4 de novembro de 2003**. Aplica "os princípios e diretrizes para a norma operacional básica de recursos humanos para o SUS (NOB/RH-SUS)" como política nacional de gestão do trabalho e da educação em saúde, no âmbito do SUS. Diário Oficial da União: Poder Executivo, Brasília, DF, 4 dez. 2003.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília,

DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016. Dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 17 nov. 2016.

BRASIL. **Lei 8080 de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União** 1990.

BRASIL. **Lei nº 15.126, de 28 de abril de 2025**. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para estabelecer a atenção humanizada como princípio no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 29 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília, **Diário Oficial da União**, 12 dez. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Declaração de Adelaide sobre Cuidados Primários**. Brasília: Ministério da Saúde, 1988b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Educação Permanente em Saúde: **um movimento instituinte de novas práticas no Ministério da Saúde: agenda 2014**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007**. Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 jan. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. **Orientações para monitoramento e avaliação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde**. Brasília, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?**^{1ª} ed. rev. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente**. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. **Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS**: caminhos para a educação

permanente em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BUENO, J. V. C. *et al.* Educação Permanente em Saúde em Prevenção e Controle das Infecções em Unidade de Emergência. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 36, p. e-021175, 2021.

CALHEIROS, M. N. T. R. *et al.* A educação permanente no âmbito da saúde mental e o médico atuante na atenção primária. **Revista APS**, v. 25, supl. 1, p. 29–40, 2022.

CAMPOS, K. F., SENA, R. R., SILVA, K. L. Permanent professional education in healthcare services. **Esc Anna Nery**, v. 21, n. 4, e20160317, 2017.

CANT, R. P.; COOPER, S. J. Simulation-based learning in nurse education: systematic review. **Journal of Advanced Nursing**, v. 66, n. 1, p. 3–15, jan. 2010.

CAPRA, M. L. P. **A educação permanente em saúde como dispositivo de gestão setorial e de produção de trabalho vivo em saúde**. 2011. Tese (Doutorado em Educação) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

CARDOSO, M. L. M. *et al.* The National Permanent Health Education Policy in Public Health Schools: reflections from practice. **Ciências & Saúde Coletiva**, v. 22, n.5, p. 1489-1500, 2017.

CASSIANI, S. H.; DIAS, B. M. Perspectives for advanced practice nursing in Brazil. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 56, spe, p. e20210406, 2022.

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 14, n. 1, p. 41–65, 2004.

CELESTE, L. E. N.; MAIA, M. R.; ANDRADE, V. A. Capacitação dos profissionais de enfermagem frente às situações de urgência e emergência na atenção primária à saúde: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e443101220521, 2021.

COOK, D. A. *et al.* Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis. **JAMA**, Chicago, v. 306, n. 9, p. 978–988, 2011.

COSTA, P. P. S.; LIMA, C. A. Direitos humanos e acesso à saúde em regiões de fronteira. **Revista Foco**, v. 16, n. 9, e3199. 2023.

CRESPO-CABUTO, A.; MORTIS-LOZOYA, S.V.; HERRERA-MEZA, S. R. Gestão curricular holística na abordagem por competências e socioformativa: um estudo exploratório. **Forma. Universidade, La Serena**, v. 14, não. 4, pág. 3-14, agosto de 2021 .

DIAS, N. T. C.; MARTINEZ, M. R. Educação permanente em saúde no Brasil: contexto histórico aos dias atuais. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 6, p. e6867, 2024.

FERREIRA, V. A.; CERDEIRA, L. A educação profissional no Brasil e em Portugal: relação com o setor produtivo. **Práx. Educ.**, Vitória da Conquista , v. 16, n. 43, p. 229-253, dez. 2020.

FIGUEIREDO, E. B. L. et al. Educação Permanente em Saúde: uma política interprofissional e afetiva. **Saúde em Debate**, v. 46, n. 135, p. 1164–73, 2022.

FONTANA, R. T. A interculturalidade na formação dos profissionais de enfermagem. **Revista Contexto & Educação**, v. 34, n. 109, p. 36–51, 2019.

FRANÇA, J. R.; AREOSA, J.; FIGUEIREDO, V. C. N. Desafios do trabalho de enfermeiras na fronteira Brasil-Bolívia. **Revista Laborativa**, v. 10, n. 1, p. 68–91, 2021.

FREIRE, P. **Educação como prática de liberdade**. 47. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020.

FURQUIM, G. G. T. Migrações internacionais no Brasil e a pandemia da Covid-19: esboço de suas consequências. **Revista Espaço Acadêmico**, v. 23, n. 240, p. 72–84, 2023.

GERMANO, J. M. *et al.* Entre nós: educação permanente em saúde como parte do processo de trabalho dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 1, p. e320110, 2022.

GIOVANELLA, L. *et al.* Saúde nas fronteiras: acesso e demandas de estrangeiros e brasileiros não residentes ao SUS nas cidades de fronteira com países do MERCOSUL na perspectiva dos secretários municipais de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, p. S251–S266, 2007.

GNOATTO, V.; MONDARDO, M. L. A fronteira como recurso social: migração de retorno de brasileiros do Paraguai em busca da saúde pública. **Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD**, [S. l.], v. 13, n. 25, p. 143–166, 2024.

HAUM, N. D. A. P.; CARVALHO, M. de. Controle social do SUS: a saúde em região de fronteira em pauta. **Saúde e Sociedade**, v. 30, n. 4, p. e200350, 2021.

HIGASHIJIMA, M. N. S. *et al.* Princípios e características da Educação Permanente em Saúde: resgate e resistência em favor de um SUS potente e em defesa da vida. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, supl. 1, 2023.

HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK (HMPGL). 2020. Disponível em: <http://www.hmpgl.com.br/>. Acesso em; 09 de set. 2024.

IGLESIAS, A. et al. Educação Permanente no Sistema Único de Saúde: concepções de profissionais da gestão e dos serviços. Psicologia: **Ciência e Profissão**, v. 43, p. e255126, 2023.

IZAGUIRRES, A. L. *et al.* Formação profissional da enfermagem para aprimoramento de competências: revisão integrativa. **Revista Recien – Revista Científica de Enfermagem**, v. 12, n. 38, p. 183–193, 2022.

JACOBOWSKI, R.; FERRO, L. F. Educação permanente em saúde e metodologias ativas de ensino: uma revisão sistemática integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e39910313391, 2021.

KHALILI, M. et al. Interventions to improve adverse drug reaction reporting: a scoping review. **Pharmacoepidemiol Drug Saf.**, v. 29, n. 9, p 965-92. 2020.

KRÜGER, C. *et al.* Analysis of public policies for developing the Brazilian border strip. **Ambiente & Sociedade**, v. 20, n. 4, p. 39–60, 2017.

LAMANTE, M. P. S.; *et al.* A educação permanente e as práticas em saúde: concepções de uma equipe multiprofissional. **Revista Pesquisa Qualitativa**, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 230–244, 2019.

LOPES, H. L. *et al.* Atuação do psicólogo em saúde do trabalhador na perspectiva psicossociológica. *Fractal: Revista de Psicologia*, v. 32, n. 1, p. 72–81, abr. 2020.

MACEDO, W. T. *et al.* The nursing professionals engagement to educational practices, **J RES Fundam Care Online**, 2019; 11(4): 1058-64.

MENANG, O. *et al.* Strategies and interventions to strengthen pharmacovigilance systems in low-income and middle-income countries: a scoping review. **BMJ Open.**, v. 13, n.9, e071079, 2023.

MERHY, E. E. **Saúde: a cartografia do trabalho vivo**. São Paulo: Hucitec, 2002. 192p.

MINAYO, M. C. S. **O desafio da pesquisa social**. In: MINAYO, M. C. S. (org.). *Pesquisa Social: teoria, método e criatividade*. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 9–29.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MUÑOZ, R. L. de S.; FREITAS, J. A. C.; SOUSA, E S. S. Qualificação docente para a formação profissional no SUS. In: MUÑOZ, Rilva Lopes de Souza; SOUSA, Eduardo Sérgio Soares (Orgs.). **Educação na saúde para o fortalecimento do SUS**. João Pessoa: UFPB, 2020.

NERY, R. F. Problemáticas de saúde pública em região de tríplice fronteira: uma revisão integrativa. **Revista Varia Scientia – Ciências da Saúde**, v. 7, n. 1, p. 48-62, 2021.

OCHOA, G.R.; BALDERAS, G. K. E. Educación continua, educación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida: coincidencias y divergencias conceptuales. **Revista Andina de Educación.**, v. 4, p. 67-73, 2021.

OGATA, M. N. *et al.* Interfaces entre a educação permanente e a educação interprofissional em saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, p. e03733, 2021.

OLIVEIRA, G. S. *et al.* **Grupo Focal: uma técnica de coleta de dados numa investigação qualitativa?** In: *Cadernos da Fucamp, UNIFUCAMP*, v.19, n.41, p.1-13, Monte Carmelo, MG, 2020.

OLIVEIRA, N. M. *et al.* Educação permanente ou continuada? Concepções de enfermeiros no cotidiano da atenção primária. **Enferm. Foco**, v. 15, e202487, 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS); FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (*ET AL*). **Declaração de Alma-Ata**. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, Alma-Ata, URSS, 6–12 set. 1978. Genebra: OMS, 1978.

Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HPR-HEP-98.1>. Acesso em: 23 jan. 2026.

OTTESEN, T. D. *et al.*, Implementation and Impact Evaluation of Virtual Orthopaedic Continuing Medical Education Conference In a Low- Resource Country. **J Surg Educ.**, v. 78, 1629-1636.20210208, 2021.

PAGOTTO, C.; VARALLO, F.; MASTROIANNI, P. Impact of educational interventions on adverse drug events reporting. **Int J Technol Assess Health Care.**v. 29, n. 4, p. 410-7, 2013.

PARENTE, A. N. *et al.* Educação permanente para qualidade e segurança do paciente em hospital acreditado. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 37, p. eAPE00041, 2024.

PAVINATI, G. *et al.* Tecnologias educacionais para o desenvolvimento de educação na saúde: uma revisão integrativa. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, 2022.

PEDUZZI, M. *et al.* Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 18, supl. 1, p. e0024678, 2020.

PEREIRA, D. O.; ROSA, S. B. Núcleo de educação permanente como ferramenta de gestão organizacional na saúde. **In: Anais do Seminário Internacional de Educação (SIEDUCA).** XXV Seminário Internacional de Educação: o sagrado e a educação: a busca de caminhos inovadores, 28-30 out. 2020, Canoas: Ulbra, 2020. v. 5, n. 1.

PINHEIRO, G. E. W.; AZAMBUJA, M. S. DE .; BONAMIGO, A. W. Facilidades e dificuldades vivenciadas na Educação Permanente em Saúde, na Estratégia Saúde da Família. **Saúde em Debate**, v. 42, n. spe4, p. 187–197, 2018.

RAMOS, J. D.N. *et al.* Educação permanente em saúde: uma estratégia para melhorar a identificação segura do paciente. **O mundo da Saúde**, v. 46, p. 153-60, e12072021, 2022.

RIBEIRO, D. K.; FRIEDRICH, D. B. C. Educação permanente em saúde e gestão do conhecimento: iniciativas na superintendência regional de saúde. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, p. e92028, 2023.

SADE, P. M. C. *et al.* Avaliação dos efeitos da educação permanente para enfermagem em uma organização hospitalar. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, p. eAPE20190023, 2020.

SILVA, R. R *et al.* Challenges of permanent education in primary health care: an integrative review. **Saúde Colet (Barueri)**. 2021;11(65):6329–33.

SOUSA, D. D. *et al.* O reflexo da educação permanente em saúde na prática de enfermagem. **Revista Sociedade Científica**, vol. 8, n. 1, p. 996-1014, 2025.

SOUSA, F. M. S. *et al.* Educação interprofissional e educação permanente em saúde como estratégia para a construção de cuidado integral na Rede de Atenção Psicossocial. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 30, n. 1, p. e300111, 2020.

SOUZA, E. N. C. *et al.* Competências do enfermeiro de saúde pública em região fronteira: revisão de escopo. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 36, p. eAPE00552, 2023.

SOUZA, E. N. DA C. *et al.* Competency mapping of primary healthcare nurses on the Brazil-Paraguay border. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 45, p. e20230098, 2024.

SOUZA, L. P. S.; DIAS, T. A.; SILVA, C. S. O. O papel da enfermagem nos 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). **Enfermagem Brasil**, [S. l.], v. 24, n. 5, p. 2766–2769, 2025.

SOUZA, R. B. Problemas e desafios da gestão pública na saúde brasileira. **Lumen e virtus**, [S. l.], v. 46, pág. 1709–1724, 2025.

STREET JUNIOR, R. *et al.* How does communication heal? Pathways linking clinician–patient communication to health outcomes. **Patient Education and Counseling**, Amsterdam, v. 74, n. 3, p. 295–301, 2009.

TIMOTEO, F. P. N. *et al.* Cuidado cultural em região de fronteira: perspectiva de enfermeiros da atenção primária à saúde. **Rev. enferm. UERJ**, v. 31, n. 1, e72771, 2023.

TURATO, E. R. **Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa**. Petrópolis: Vozes, 2003.

UBESSI, L. D. *et al.* Educação Permanente em Saúde: experimentando jeitos de ver, viver, sentir e tecer o Sistema Único de Saúde. **Saberes Plurais em Educação e Saúde**, v. 4, n. 2, p. 71-80, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde**. Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, Ottawa, Canadá, 17–21 nov. 1986. Genebra: OMS, 1986. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HPR-HEP-95.1>. Acesso em: 23 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **WHO patient safety curriculum guide: multi-professional edition**. Geneva: WHO, 2009. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44091> Acesso em: 18 nov. 2025.

YAMAMOTO, T. S.; MACHADO, M. T. C.; SILVA JUNIOR, A. G. Educação permanente em saúde como prática avaliativa amistosa à integralidade em Teresópolis, Rio de Janeiro. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 13, n. 3, p. 617–638, set. 2015.

ZÚNIGA C *et al.*,. Formación continua: estrategias y barreras para su implementación en hospitales centinela para la vigilancia de la seguridad de vacunas contra la COVID-19 en Honduras, 2022-2023. **Rev Panam Salud Publica.**, v. 48, e112, 2024.

APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA A ENTREVISTA

Instruções: Suas respostas contribuirão para a melhoria contínua dos processos de capacitação e desenvolvimento no hospital.

Dados Demográficos

1. Qual é o seu cargo atual?
☐ Enfermeiro(a)
☐ Técnico(a) de Enfermagem
☐ Auxiliar de Enfermagem
 2. Quanto tempo atua neste Hospital: _____
 3. Qual a sua idade? _____
 4. Qual é o seu nível de formação?
☐ Ensino Médio
☐ Graduação
☐ Pós-graduação
☐ Mestrado ou superior
-

SEÇÃO 1: PARTICIPAÇÃO E FREQUENCIA NAS ATIVIDADES DE EPS

- 1.1 Quantas vezes você participou de atividades de treinamentos ou capacitações nos últimos 12 meses?
- 1.2 Fale-me sobre sua participação nas atividades de EPS. Como é para você participar? Você encontra dificuldades para participar dessas atividades? Por quê?

SEÇÃO 2: AVALIAÇÃO DOS TEMAS E CONTEÚDOS DAS FORMAÇÕES

- 2.1 Fale sobre os temas abordados das capacitações que você participou e se eles atenderam ou não a sua necessidade de desenvolvimento.
- 2.2 Fale sobre alguma capacitação em especial te ajudou na práticas assistencial e como.
- 2.3 Fale em quais áreas você acredita que seria importante capacitação e os motivos.
- 2.4 Você acredita que os temas abordados nas capacitações são adequados? Se sim ou se não, a que você atribui isso?
- 2.5 A variedade dos temas abordados nas capacitações é suficiente para atender às suas necessidades de desenvolvimento?
- 2.6. Essas capacitações te ajudaram na prática cotidiana? De que maneira?
- 2.7 Em quais áreas você acredita que seriam necessárias mais capacitações? Por que você acredita nisso?
- 2.8 Quais temas você gostaria de ver incluídos nas capacitações futuras? Justifique sua escolha.

SEÇÃO 3: QUALIDADE DOS TREINAMENTOS E FORMAÇÕES

- 3.1 Como você avalia o nível de aprofundamento dos conteúdos apresentados nas capacitações e treinamentos realizados pelo NEPE?
- 3.2 Em sua opinião a qualificação dos palestrantes influencia na qualidade da capacitação? Por quê?
- 3.3 Conte se a metodologia utilizada (ex.: palestras, estudos de caso, simulações) contribuiu para o seu aprendizado efetivo? Como foram as atividades que você participou?

- 3.4 Como você sugeria melhorias na metodologia e conteúdo das capacitações?
- 3.5 O conteúdo das capacitações é atualizado conforme as mudanças e novas diretrizes na área da saúde?

SEÇÃO 4: IMPACTOS DOS TREINAMENTOS NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

- 4.1 Conte-me sobre as contribuições que esses treinamentos e capacitações refletem no seu dia a dia, como eles auxiliam na melhoria do cuidado e segurança do paciente?
- 4.2 Como elas contribuem para a comunicação e tomada de decisões no seu ponto de vista?
- 4.3 Como as capacitações contribuem para o desenvolvimento das habilidades de trabalho em equipe?
- 4.4 Como os treinamentos contribuíram para reduzir erros e aumentar a segurança no atendimento ao paciente? De que jeito?
- 4.5 Após participar das capacitações e treinamentos, quais melhorias você percebeu na sua confiança para executar tarefas específicas?
- 4.6 Como as capacitações ajudam a aplicar na prática as diretrizes e protocolos estabelecidos pelo hospital e normativas de saúde?

SEÇÃO 5: SATISFAÇÃO E SUGESTÕES PARA MELHORIAS

- 5.1 Como você avalia o horário que são oferecidas as capacitações? Você acha que teriam horários melhores para realizar essas atividades?
- 5.2 Como você avalia o apoio institucional para a participação nas atividades de EPS?
- 5.3 Que melhorias você sugeriria para os programas de capacitação oferecidos pelo NEPE?
- 5.4 Há temas ou áreas que você gostaria que fosse incluídos nas futuras capacitações?
- 5.5 Qual o nível de engajamento dos profissionais de saúde nas atividades educativas?
- 5.6 O que, em sua opinião, poderia aumentar o engajamento dos profissionais?

SEÇÃO 6: AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA

- 6.1 Você considera que a instituição oferece recursos suficientes para a realização das atividades de EPS como materiais, equipamentos e espaços para a realização dos encontros?
- 6.2 Como você avalia a qualidade dos materiais utilizados nas capacitações, como apresentações, folhetos ou dinâmicas?
- 6.3 O hospital oferece apoio para participação em curso externos, como congressos e oficinas na área da saúde?

SEÇÃO 7: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS EM LONGO PRAZO

- 7.1 Você percebe que o ambiente no hospital é mais favorável ao aprendizado e à educação permanente?
- 7.2 O hospital oferece suporte para que você possa aplicar as novas práticas adquiridas nas capacitações?
- 7.3 A Educação em Saúde no Hospital tem promovido uma cultura de aprendizado contínuo e adaptação às novas demandas?

Comentário final: Caso tenha sugestões ou comentários adicionais sobre as atividades de Educação em Saúde do hospital, descreva-os abaixo:

APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Convidamos você a participar de uma pesquisa intitulada “A educação permanente em saúde: um olhar da enfermagem sobre as práticas educativas do setor de núcleo de educação, pesquisa e extensão de um hospital público em região de fronteira”. O objetivo desta pesquisa é o de avaliar as práticas educativas segundo a percepção dos profissionais enfermeiros; e têm o propósito de demonstrar o quanto esse procedimento de ensino é importante também para a área da saúde. Para que isso ocorra você será convidado a participar de uma entrevista.

Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação, como constrangimento, em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização. Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo.

Também você poderá a qualquer momento desistir de participar da pesquisa sem qualquer prejuízo. Para que isso ocorra, basta informar, por qualquer modo que lhe seja possível, que deseja deixar de participar da pesquisa e qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na avaliação dos resultados.

A participação na pesquisa não trará nenhum comprometimento profissional ou para as relações no local de trabalho do(s) respondente(s). A participação é voluntária e todo e qualquer participante possui acesso aos resultados, podendo retirar-se da pesquisa em qualquer circunstância sem nenhum prejuízo; e o participante tem garantido o direito de solicitar indenização através das vias judiciais. A recusa não implicará em nenhum prejuízo pessoal ou profissional.

Se ocorrer algum transtorno, decorrente de sua participação em qualquer etapa desta pesquisa, nós pesquisadores, providenciaremos acompanhamento e a assistência imediata, integral e gratuita. Havendo a ocorrência de danos, previstos ou não, mas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caberá a você, na forma da Lei, o direito de solicitar a respectiva indenização.

Os riscos envolvidos nesta pesquisa são a exigência de tempo para resposta ao momento da entrevista que possui duração estimada de 45 a 60 minutos.

Nós pesquisadores garantimos a privacidade e o sigilo de sua participação em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço, voz e imagem nunca serão associados aos resultados desta pesquisa. separado separadamente deste.

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para autorizar novamente o uso. Juliana Marçal e a Dr^a Thais Fernanda Tortorelli Zarili, docente do Programa de Pós-graduação em Região de Fronteira da UNIOESTE Campus Foz do Iguaçu.

Este documento que você vai assinar contém duas páginas. Você deve vistar (rubricar) todas as páginas, exceto a última, onde você assinará com a mesma assinatura registrada no cartório (caso tenha). Este documento está sendo apresentado a você em duas vias, sendo que uma via é sua. Sugerimos que guarde a sua via de modo seguro.

Caso você precise informar algum fato ou decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 as 15h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619 –Bairro Universitário, Cascavel – PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo

telefone do CEP que é (45) 3220-3092. Contato da orientadora da pesquisa e-mail: thaisftzarili@gmail.com ou telefone: (14) 98132-6229. Contato do pesquisador e-mail: marcal-juliana@hotmail.com ou telefone: (45) 99914-6418.

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar da avaliação.

Nome do participante da pesquisa: _____

Assinatura: _____

Eu, Thais Fernanda Tortorelli Zarili , declaro que forneci todas as informações sobre este projeto de pesquisa ao participante.

Assinatura do pesquisador

Assinatura do orientador

Foz do Iguaçu , _____ de _____ de 20____.

ANEXO 1 – TERMO DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Educação Permanente em Saúde: um Olhar da Enfermagem sobre as Práticas Educativas do Setor de Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão de um Hospital Público em Região de Fronteira

Pesquisador: Thais Fernanda Tortorelli Zanili

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 88991625.7.0000.0107

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.668.903

Apresentação do Projeto:

O estudo tem abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, que utilizará entrevistas semiestruturadas com a equipe de enfermagem para avaliar as atividades de educação permanente do setor utilizando a técnica de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo. A pesquisa envolverá enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da instituição.

Objetivo da Pesquisa:

O objetivo do estudo consiste em analisar as práticas educativas do setor de Núcleo de Educação, Pesquisa e Extensão de um Hospital Público em região de fronteira, sob a perspectiva da equipe de enfermagem. Compreender a percepção dos profissionais da equipe de enfermagem sobre as práticas educativas do NEPE que participaram;

Analisar as mudanças que ocorreram após a formação e treinamentos na visão da equipe de enfermagem.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Possíveis riscos: 1- cansaço ou aborrecimento ao responder questionários;

2- alterações na autoestima provocadas pela evocação de memórias sobre questões de sua

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.668.903

atividade laboral;

3- Tomar o tempo do sujeito ao responder ao questionário/entrevista. O presente estudo será realizado no setor em que a mestrandia atua profissionalmente. A pesquisa tem como objetivo compreender as percepções dos funcionários do hospital sobre as ações promovidas por esse setor. Reconhecendo-se a possível existência de conflito de interesses e desequilíbrio na relação pesquisador participante, serão adotadas medidas éticas rigorosas para garantir a autonomia, o sigilo e a confidencialidade dos participantes. A participação será totalmente voluntária, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual deixará explícito que a decisão de participar ou não da pesquisa não acarretará qualquer prejuízo ou benefício profissional. Será assegurado o anonimato das informações coletadas, e os dados serão apresentados de forma agregada, sem qualquer identificação direta ou indireta dos participantes.

Benefícios:

Com as práticas de educação permanente estruturadas após a análise dos resultados do presente estudo, pode-se gerar impactos positivos significativos para a equipe de enfermagem e para os pacientes atendidos pelo hospital. Um dos principais benefícios é a qualificação dos profissionais de saúde, que passam a ter acesso contínuo a atualizações e aprimoramentos de suas habilidades, refletindo diretamente na qualidade da assistência prestada. A EPS também contribui para a redução de erros clínicos e operacionais, uma vez que profissionais bem treinados conseguem atuar com maior segurança e eficiência, evitando falhas que comprometam o cuidado ao paciente.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Projeto de dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública em Região de Fronteira-Mestrado, do Centro de Educação Letras e Saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Saúde Pública.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- 1- Folhas de Rosto - apensado e adequado.
- 2- TCLE - apensado e adequado.
- 3- Projeto detalhado - apensado e adequado.
- 4- Termo de ciência do responsável do campo de estudo - apensado e adequado.
- 5- Termo de compromisso para dados em arquivos - apensado e adequado.
- 6- Declaração de pesquisa não iniciada - apensado e adequado.

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3082

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE**



Continuação do Parecer: 7.668.903

7- Cronograma - apensado e adequado.

8- Orçamento - apensado e adequado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Projeto de pesquisa adequado do ponto de vista ético envolvendo seres humanos conforme exigências da Resolução 466/12.

Considerações Finais a critério do CEP:

O pesquisador deverá entregar o relatório Final, assim que concluir o estudo.

A desistência do estudo ou qualquer alteração ocorrida deverá ser comunicada, por emenda, apensada na Plataforma Brasil.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2554614.pdf	25/05/2025 19:19:56		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_BROCHURA.pdf	25/05/2025 18:41:08	JULIANA MARCAL	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA.pdf	25/05/2025 16:04:02	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	AUTORIZACAO.pdf	25/05/2025 16:01:48	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
Outros	TERMO.pdf	25/05/2025 16:01:36	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	coparticipante.pdf	25/05/2025 16:01:18	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
Outros	INTERVENCAO.pdf	25/05/2025 16:00:45	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
Outros	FORMULARIO.pdf	25/05/2025 15:58:59	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
Declaração de Pesquisadores	DADOS.pdf	25/05/2025 15:58:49	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_CEP.pdf	25/05/2025 15:56:26	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619
Bairro: UNIVERSITARIO
UF: PR Município: CASCAVEL
Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 7.668.903

Folha de Rosto	FolhaderostoJuliana.pdf	13/05/2025 15:24:18	Thais Fernanda Tortorelli Zarili	Aceito
----------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 26 de Junho de 2025

Assinado por:
Franciele Foschiera Camboin
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619
Bairro: UNIVERSITARIO
UF: PR Município: CASCADEL
Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prpg@unioeste.br

Página 04 de 04